



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KESEHATAN REPRODUKSI DI ERA MODERN

Baiq Eka Putri Saudia • Emilda • Irnawati
Tinuk Esti Handayani • Ayuk Novalina

Editor: Junay darmawati



BUNGA RAMPAI: KESEHATAN REPRODUKSI DI ERA MODERN

Penulis:

Baiq Eka Putri Saudia, S.SiT., M.Keb.

Emilda AS., SST., MPH.

Dr. Irnawati. S.SiT., M.Kes.

Tinuk Esti Handayani, SST., M.Kes.

Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor:

Junay darmawati, S.ST., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Kesehatan Reproduksi di Era Modern

Penulis: Baiq Eka Putri Saudia, S.SiT., M.Keb.

Emilda AS., SST., MPH.

Dr. Irnawati. S.SiT., M.Kes.

Tinuk Esti Handayani, SST., M.Kes.

Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor: Junay darmawati, S.ST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-40-4

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "***Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi di Era Modern***" ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi kami terhadap isu-isu kesehatan reproduksi yang semakin kompleks seiring dengan dinamika zaman.

Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga kesehatan reproduksi menjadi semakin beragam. Tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, namun juga menyangkut faktor gaya hidup, budaya, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh dan pendekatan yang adaptif sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan di bidang ini.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai isu aktual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dengan penyajian berbasis kajian ilmiah dan praktik lapangan, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENGARUH POLA HIDUP TERHADAP KESEHATAN

REPRODUKSI.....	1
Baiq Eka Putri Saudia, S.SiT., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Polarisasi Pola Hidup Berdasarkan Masalah Reproduksi	1
C. Dampak Pola Hidup Tidak Sehat Terhadap Kesehatan Reproduksi.....	4
D. Simpulan	14
E. Referensi	14
F. Glosarium	18

CHAPTER 2 PERAN BIDAN DALAM MENJAGA KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA.....	19
Emilda AS, SST., MPH.....	19
A. Pendahuluan/Prolog	19
B. Kesehatan Reproduksi di Era Modern	20
C. Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi Remaja.....	23
D. Implementasi Praktis.....	27
E. Simpulan	29
F. Referensi	30
G. Glosarium	31

CHAPTER 3 PERAWATAN KESEHATAN SEKSUAL PADA IBU PASCA

PERSALINAN.....	33
Dr. Irnawati, S.SiT., M.Kes.	33
A. Pendahuluan/Prolog	33
B. Kesehatan Seksual.....	34
C. Perawatan Kesehatan Seksual.....	35
D. Permasalahan Kesehatan Seksual Pada Ibu Pasca Persalinan.....	36
E. Perawatan Kesehatan Seksual Pada Ibu Pasca Persalinan.....	40
F. Simpulan	44
G. Referensi	44

CHAPTER 4 TREN KONTRASEPSI MODERN: PILIHAN DAN TANTANGANNYA47

Tinuk Esti Handayani, SST., M.Kes.	47
A. Pendahuluan/Prolog	47
B. Tantangan Dalam Penggunaan Kontrasepsi Modern	48
C. Keluarga Berencana.....	53
D. Metode Kontrasepsi Modern	55
E. Simpulan	58
F. Referensi	58
G. Glosarium	59

CHAPTER 5 PENCEGAHAN KANKER SERVIKS MELALUI EDUKASI DAN VAKSINASI61

Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb.....	61
A. Pendahuluan	61
B. Kanker serviks	62
C. Etiologi Kanker Serviks.....	63
D. Faktor Risiko	64
E. Gejala kanker serviks.....	66
F. Pencegahan Kanker Serviks.	68
G. Infeksi Human Papilloma Virus.....	71
H. Fokus Vaksinasi HPV pada Remaja Putri.....	71
I. Pentingnya Edukasi dalam Pencegahan Kanker Serviks.....	72
J. Sasaran Edukasi Kesehatan	73
K. Strategi Efektif dalam Edukasi Pencegahan Kanker Serviks.....	74
L. Tantangan dalam Pelaksanaan Edukasi	75
M. Studi Kasus dan Best Practice tentang Edukasi Pencegahan Kanker Serviks	76
N. Kesimpulan.....	77
O. Referensi	77
P. Glosarium	78

PROFIL PENULIS79

CHAPTER 1

PENGARUH POLA HIDUP TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

Baiq Eka Putri Saudia, S.SiT., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan reproduksi wanita merupakan aspek penting dalam kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial. Kesehatan reproduksi yang baik tidak hanya berkaitan dengan fungsi organ reproduksi, tetapi juga mencakup keseimbangan hormonal, kesuburan, serta perlindungan dari penyakit yang dapat mengganggu sistem reproduksi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mendukung kualitas hidup secara keseluruhan (Hajrija & Ankica, 2024).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan reproduksi wanita adalah pola hidup. Pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, manajemen stres yang baik, serta kebiasaan tidur yang teratur berperan dalam menjaga keseimbangan sistem reproduksi. Sebaliknya, pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, kurangnya aktivitas fisik, stres berlebihan, merokok, serta konsumsi alkohol, dapat mengganggu fungsi hormonal dan meningkatkan risiko gangguan reproduksi, seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), infertilitas, serta gangguan menstruasi (Mathias & Somieye, 2021).

Dampak pola hidup yang tidak sehat terhadap sistem reproduksi wanita menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Misalnya, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan resistensi insulin yang berkontribusi terhadap PCOS, sementara stres berkepanjangan dapat mengganggu siklus menstruasi dan menurunkan kesuburan. Selain itu, paparan zat berbahaya seperti rokok dan alkohol dapat berdampak negatif terhadap kualitas sel telur dan meningkatkan risiko penyakit reproduksi lainnya (Nirmin F et al., 2023).

B. Polarisasi Pola Hidup Berdasarkan Masalah Reproduksi

Masalah kesehatan reproduksi sering dikaitkan dengan kesulitan dalam menjalani pola hidup sehat. Seseorang yang memiliki pemahaman dan penanganan yang baik terhadap kesehatan reproduksinya lebih cenderung menjalani pola hidup sehat dan menjaga keseimbangan emosional mereka.

Polarisasi pola hidup berdasarkan masalah reproduksi merujuk pada pemisahan atau perbedaan gaya hidup yang terjadi akibat adanya masalah dalam kesehatan reproduksi. Masalah reproduksi dapat menyebabkan individu atau kelompok mengadopsi pola hidup yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan kebutuhan kesehatan mereka. Polarisasi ini bisa dilihat dalam beberapa aspek berikut (Mathias & Somieye, 2021):

1. Pola hidup sehat dengan pola hidup yang terpengaruh masalah reproduksi

- a. Pola hidup sehat merupakan individu yang tidak mengalami masalah kesehatan reproduksi umumnya dapat menjalani pola hidup yang lebih fleksibel, dengan kebiasaan makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga keseimbangan emosional yang baik. Mereka cenderung lebih mampu merencanakan keluarga, menjaga kesehatan seksual, dan menghindari penyakit menular seksual (PMS).
- b. Pola hidup yang terpengaruh masalah reproduksi merupakan individu yang menghadapi masalah reproduksi, seperti gangguan kesuburan, menstruasi yang tidak teratur, endometriosis, atau penyakit menular seksual, sering kali harus mengadopsi pola hidup yang lebih terbatas. Mungkin membutuhkan perawatan medis lebih sering, pembatasan aktivitas tertentu, atau perubahan diet dan gaya hidup untuk mengelola kondisi tersebut.

2. Pengaruh gangguan kesuburan

- a. Pola hidup berfokus pada perawatan kesuburan yaitu mereka yang menghadapi masalah kesuburan sering kali mengikuti pola hidup yang berfokus pada perawatan medis, seperti terapi kesuburan *in vitro fertilization* (IVF) / inseminasi buatan, perubahan pola makan, pengelolaan stres, atau konsumsi suplemen untuk mendukung kesehatan reproduksi (Neneng & Desri, 2021).
- b. Pola hidup tanpa gangguan kesuburan, sebaliknya individu yang tidak memiliki masalah kesuburan mungkin menjalani kehidupan lebih baik dalam hal perencanaan keluarga tanpa perlu melalui prosedur medis.

3. Masalah kesehatan reproduksi pada perempuan

- a. Pola hidup yang berfokus pada kesehatan reproduksi yaitu wanita yang mengalami gangguan reproduksi, seperti endometriosis, fibroid, atau Polycystic Ovary Syndrom (PCOS), wanita yang memerlukan perawatan yang lebih terencana sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap pola makan, olahraga, serta pengelolaan stres yang lebih ketat untuk mengurangi gejala (D Abdulkhalikova et al., 2022).
- b. Pola hidup tanpa gangguan reproduksi yaitu wanita yang tidak mengalami masalah reproduksi, umumnya memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam

menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terbebani oleh kondisi medis yang mempengaruhi sistem reproduksi mereka.

4. Perbedaan dalam perawatan kesehatan seksual dan reproduksi

- a. Pola hidup dengan akses terbatas yaitu beberapa individu, terutama di daerah yang kurang terlayani, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses perawatan kesehatan reproduksi yang memadai. Hal ini bisa mengakibatkan perbedaan dalam kualitas hidup dan kemampuan untuk mengelola masalah kesehatan reproduksi.
- b. Pola hidup dengan akses lengkap yaitu mereka yang memiliki akses lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan kesehatan reproduksi, dan informasi tentang keluarga berencana biasanya dapat mengelola masalah kesehatan reproduksi dengan lebih baik, yang berujung pada pola hidup yang lebih seimbang.

5. Kesehatan mental dan emosional

- a. Pola hidup yang dipengaruhi oleh masalah reproduksi yaitu gangguan kesehatan reproduksi sering kali memiliki dampak besar pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Rasa frustrasi, depresi, atau kecemasan seringkali muncul, yang menyebabkan individu menghadapi kesulitan dalam menjaga pola hidup sehat. Mereka mungkin menghindari aktivitas sosial atau merasa tertekan dalam menghadapi masalah reproduksi yang dialami (Roozitalab et al., 2021).
- b. Pola hidup yang lebih stabil secara mental merupakan individu yang tidak menghadapi masalah reproduksi cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih stabil, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

6. Dampak sosial dan budaya

- a. Stigma sosial, dalam beberapa budaya masalah kesehatan reproduksi dapat menimbulkan stigma atau rasa malu. Misalnya, gangguan kesuburan atau masalah seksual dapat menyebabkan individu merasa diisolasi atau dikucilkan. Ini berpotensi memperburuk polarisasi pola hidup antara mereka yang menghadapi masalah reproduksi dan yang tidak.
- b. Toleransi sosial, di masyarakat yang lebih menerima dan terbuka terhadap diskusi mengenai kesehatan reproduksi, individu cenderung merasa lebih didukung, sehingga dapat menjalani pola hidup yang lebih sehat dan seimbang (Fatma et al., 2023).

C. Dampak Pola Hidup Tidak Sehat Terhadap Kesehatan Reproduksi

1. Nutrisi

Pola makan berperan penting dalam kesehatan reproduksi wanita karena nutrisi memengaruhi fungsi hormon, ovulasi, kualitas sel telur, dan keseimbangan metabolik tubuh. Gangguan nutrisi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, infertilitas, hingga komplikasi kehamilan (Audrey J, et al., 2019).

World Health Organization (WHO) melaporkan hingga saat ini menemukan data bahwa hingga 80 juta wanita di seluruh dunia mengalami infertilitas, dengan prevalensi 50% dari seluruh wanita di negara berkembang. Selain sejumlah penyakit ginekologi dan sistemik yang mempengaruhi kesuburan wanita, faktor gaya hidup dan kondisi lingkungan seperti pekerjaan yang penuh tekanan, nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang tidak sehat juga mengganggu keamanan reproduksi baik pada wanita maupun pria. Oleh karena itu, berat badan yang tidak normal dan pasokan energi dalam hal pembatasan atau kelebihan, serta kelebihan makanan dengan kandungan karbohidrat, asam lemak, protein, vitamin dan mineral semuanya memberikan dampak buruk pada fungsi ovulasi dan spermatogenesis normal. Selain gangguan negatif terhadap keamanan gamet, beberapa nutrisi dari makanan utama juga mempengaruhi implantasi embrio (Oostingh EC et al., 2019).

Kesehatan reproduksi tentunya dipengaruhi oleh makanan dan jenis nutrisi. Asupan kalori dan protein yang tidak seimbang akibat konsumsi makanan yang salah, menyebabkan berat badan kurang atau berlebih, menyebabkan perubahan fungsi ovarium yang selanjutnya meningkatkan infertilitas. Beberapa penelitian yang mengeksplorasi pengaruh berbagai kebiasaan makan terhadap kesuburan didasarkan pada data dari penelitian lanjutan yang melibatkan 116.678 wanita dalam Nurses' Health Study II, yang mendefinisikan penurunan risiko kesuburan karena gangguan ovulasi pada wanita yang pola makannya mencakup kandungan glikemik rendah dan asupan nutrisi yang terbatas.

Variasi berat badan dalam hal kelebihan berat badan, obesitas atau kekurangan berat badan yang parah terkait dengan perubahan keseimbangan energi juga diduga menyebabkan gangguan ovulasi. Dalam hal ini, telah dilaporkan bahwa waktu untuk hamil lebih lama pada wanita dengan indeks massa tubuh (IMT) lebih dari 25 kg/m² atau lebih rendah dari 19 kg/m², dan baik kelebihan berat badan maupun obesitas berhubungan secara signifikan dengan penurunan angka kehamilan, peningkatan pasokan gonadotropin, dan angka keguguran yang lebih tinggi. IMT yang tinggi juga dikaitkan dengan abortus seperti diabetes gestasional, hipertensi dan kelahiran prematur dan pola makan

yang tidak seimbang dengan prevalensi karbohidrat, asam lemak, protein atau vitamin dan zat gizi mikro pasti berdampak negatif pada ovulasi. Selain itu, faktor nutrisi tidak hanya mempengaruhi pematangan oosit, tetapi juga kualitas embrio dan efisiensi implantasi (Erica S et al., 2019).

Dampak pola makan terhadap kesehatan reproduksi wanita sebagai berikut:

a. Gangguan siklus menstruasi dan ovulasi

Pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan ovulasi dan siklus menstruasi akibat perubahan hormon.

1) Defisiensi kalori dan lemak

Diet rendah kalori dan rendah lemak (misalnya anoreksia atau diet ekstrem) dapat menyebabkan penurunan hormon leptin, yang berperan dalam mengatur GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone). GnRH yang rendah menyebabkan gangguan pelepasan FSH (Follicle-Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone), yang penting untuk ovulasi dan siklus menstruasi.

2) Asupan berlebih karbohidrat dan resistensi insulin

Pola makan tinggi gula dan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan resistensi insulin, menyebabkan hiperinsulinemia yang merangsang produksi androgen berlebihan oleh ovarium. Hal ini menyebabkan gangguan ovulasi dan menstruasi, seperti yang terjadi pada Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) (Yujie Shang et al, 2020).

b. Dampak pada keseimbangan hormon seksual

1) Protein dan Lemak

Konsumsi lemak trans dan rendahnya asupan protein yang baik dapat menurunkan produksi estrogen dan progesteron, yang berdampak pada gangguan kesuburan.

2) Defisiensi Zinc dan Vitamin B6

Dapat mengganggu sintesis hormon progesteron, yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan implantasi embrio.

c. Pola makan dan risiko PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

PCOS adalah gangguan hormonal yang berhubungan erat dengan pola makan dan metabolisme. Hiperinsulinemia akibat pola makan tinggi karbohidrat sederhana dapat memicu overproduksi androgen oleh ovarium sehingga dapat menghambat ovulasi dan menyebabkan anovulasi kronis. Selain itu peradangan sistemik akibat pola makan tinggi lemak jenuh dapat memperburuk resistensi insulin dan ketidakseimbangan hormon (Yujie Shang et al, 2020).

d. Dampak pada kesuburan dan kehamilan

1) Defisiensi mikronutrien:

(a) Asam folat

Kekurangan asam folat dapat meningkatkan risiko cacat tabung saraf pada janin.

(b) Zat besi

Kekurangan zat besi menyebabkan anemia yang berdampak negatif pada implantasi embrio.

(c) Omega-3

Defisiensi asam lemak omega-3 mengganggu perkembangan folikel ovarium dan meningkatkan risiko keguguran (Permatasari, et al., 2021).

2) Obesitas dan sindrom metabolik

Pola makan tinggi lemak jenuh dan gula dapat menyebabkan obesitas, yang berhubungan dengan disfungsi ovulasi, resistensi insulin, dan inflamasi kronis, sehingga menurunkan tingkat kesuburan (Audrey J, et al., 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara kesuburan wanita dan perilaku pola makan. Keseimbangan protein, karbohidrat, lipid, antioksidan dan folat yang tepat dalam makanan sehari-hari memberikan manfaat penting untuk kesehatan reproduksi wanita yang optimal dan mengurangi risiko infertilitas. Asupan antioksidan yang cukup juga mendukung fungsi reproduksi wanita karena suplemen yang mengandung asam folat, β -karoten, Vitamin C dan E, serta dukungan nutrisi yang cukup pasti efisien dalam mempersingkat waktu terjadinya ovulasi.

2. Merokok

Merokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi wanita, baik secara langsung melalui bahan kimia beracun dalam rokok maupun secara tidak langsung melalui gangguan hormon dan suplai darah. Penelitian yang dilakukan Firms et al (2015) dengan mengevaluasi dampak faktor gaya hidup ini terhadap hasil fertilisasi in vitro (IVF) pada 351 pasangan yang datang ke PIVET Medical Centre di Australia Barat. Meneliti kuantitas oosit, tingkat pembuahan, kehamilan, dan keguguran dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa merokok sangat merusak kualitas gamet pada kedua jenis kelamin yang mengakibatkan penurunan jumlah ovarium pada wanita, dan penurunan signifikan dalam kualitasnya. Sedangkan pada pria menurunkan jumlah, mobilitas dan morfologi sperma (Omolaoye et al., 2022).

Adapun dampak merokok pada sistem reproduksi wanita (De Angelis et al., 2020) :

a. Gangguan fungsi ovarium dan kesuburan

1) Stres oksidatif

Kandungan radikal bebas dalam asap rokok (seperti nikotin, karbon monoksida, dan benzopyrene) menyebabkan stres oksidatif pada ovarium, yang merusak oosit (sel telur) dan mempercepat penuaan ovarium.

2) Gangguan hormonal

Merokok menurunkan kadar estrogen dengan cara meningkatkan metabolisme estrogen di hati, sehingga dapat mengganggu pematangan folikel dan ovulasi.

3) Resistensi ovarium

Nikotin dan senyawa lain dalam rokok dapat mengurangi respons ovarium terhadap hormon perangsang folikel (FSH), yang berakibat pada kesulitan ovulasi dan berkurangnya peluang kehamilan.

4) Menopause dini

Merokok mempercepat penurunan cadangan ovarium sehingga meningkatkan risiko menopause dini sekitar 1-4 tahun lebih awal dibandingkan wanita yang tidak merokok.

b. Gangguan pada siklus menstruasi

1) Siklus anovulasi

Paparan bahan kimia dari rokok dapat mengganggu produksi hormon luteinizing (LH) dan FSH, menyebabkan gangguan ovulasi.

2) Dismenore (nyeri haid)

Merokok meningkatkan prostaglandin yang dapat menyebabkan kontraksi uterus lebih kuat dan memperparah nyeri menstruasi.

3) Perdarahan tidak teratur

Perubahan kadar hormon akibat merokok sering menyebabkan gangguan siklus menstruasi, seperti siklus yang lebih pendek atau lebih panjang, dan perdarahan yang lebih banyak atau lebih sedikit (Maqbool R et al., 2022).

c. Peningkatan risiko infertilitas

1) Wanita perokok memiliki risiko infertilitas 2 kali lebih tinggi dibandingkan non-perokok akibat berkurangnya kualitas oosit dan gangguan implantasi embrio (De Angelis et al., 2020) .

2) Endometrium yang terpapar bahan kimia dari rokok memiliki reseptivitas yang lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko kegagalan kehamilan.

- 3) Tingginya kadar karbon monoksida dalam darah dapat mengurangi oksigenasi ke ovarium dan uterus, mengganggu perkembangan folikel dan dinding rahim (Neneng & Desri., 2021).
- d. Peningkatan Risiko Kehamilan Ektopik

Nikotin mempengaruhi motilitas tuba falopi dengan cara mengganggu kerja silia yang berfungsi menggerakkan sel telur ke rahim. Akibatnya, embrio yang telah dibuahi lebih mungkin tertahan di tuba falopi, meningkatkan risiko kehamilan ektopik.
- e. Dampak pada Kehamilan
 - 1) Risiko keguguran

Merokok dapat menyebabkan insufisiensi plasenta (plasenta tidak berkembang dengan baik), sehingga meningkatkan risiko keguguran.
 - 2) Retardasi pertumbuhan janin

Nikotin menyempitkan pembuluh darah ke plasenta, mengurangi aliran darah dan oksigen ke janin, menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah.
 - 3) Abruptio plasenta

Paparan rokok meningkatkan risiko solusio plasenta, yaitu kondisi di mana plasenta terlepas sebelum persalinan, yang berisiko menyebabkan perdarahan hebat.
 - 4) Persalinan prematur

Merokok meningkatkan risiko kelahiran prematur akibat inflamasi dan gangguan vaskular plasenta (Avsar TS et al., 2021).
- f. Gangguan pada fungsi seksual
 - 1) Penurunan libido

Berkurangnya kadar estrogen akibat merokok dapat mengurangi gairah seksual dan menyebabkan kekeringan vagina.
 - 2) Disfungsi seksual

Aliran darah ke organ genital dapat terganggu akibat efek vasokonstriksi nikotin, menyebabkan kesulitan dalam mencapai orgasme.
- g. Peningkatan risiko kanker reproduksi
 - 1) Kanker serviks

Merokok meningkatkan risiko infeksi persisten HPV (Human Papillomavirus), yang merupakan penyebab utama kanker serviks.
 - 2) Kanker endometrium

Pada wanita pascamenopause, merokok dapat mengubah metabolisme estrogen, yang dapat meningkatkan risiko kanker endometrium.

3) Kanker ovarium

Merokok dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker ovarium tipe sel mukosa.

3. Pola Tidur/Istirahat

Siklus reproduksi tidak hanya memengaruhi tidur, namun tidur juga memengaruhi fungsi reproduksi. Durasi, waktu, dan kualitas tidur dapat memengaruhi sistem reproduksi, yang dampaknya bergantung pada kematangan reproduksi. Selama masa pubertas, LH dilepaskan secara pulsatil, yang memainkan peran penting dalam regulasi reproduksi. Di masa dewasa, arah hubungan berubah pada fase folikuler awal, dengan tidur yang menghambat sekresi LH pulsatil, yang dianggap penting dalam perkembangan folikel ovarium (Beroukhim G et al., 2022).

Ada laporan tentang hubungan antara durasi tidur pendek dan perubahan siklus menstruasi pada remaja dan orang dewasa. Wanita yang melaporkan tidur kurang dari 6 jam lebih mungkin melaporkan panjang siklus menstruasi yang tidak normal (pendek atau panjang) dalam sebuah survei terhadap remaja, durasi tidur pendek (<5 jam) secara signifikan dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan ketidakaturan siklus menstruasi, bahkan setelah disesuaikan dengan variabel perancu (Esther E et al., 2021). Ada banyak penelitian yang menyelidiki dampak kerja shift terhadap fungsi reproduksi pada wanita, mengingat gangguan tidur dan pola sirkadian yang umum terjadi (Kervezee L et al., 2018).

4. Aktivitas Fisik

Fungsi reproduksi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan reproduksi yang baik mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh keturunan dan mendukung kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi adalah olahraga teratur. Sehingga pentingnya olahraga teratur dalam menjaga fungsi reproduksi cukup penting untuk dilakukan. Demi menambah semangat berolahraga agar fungsi reproduksi terjaga dengan baik (Minhal et al., 2023).

Aktivitas fisik telah terbukti bermanfaat dalam mencegah infertilitas, Assisted Reproductive Technology (ART), PCOS, pencegahan penambahan berat badan, dan kesejahteraan psikologis. Karena tingkat aktivitas prakonsepsi merupakan penentu berkelanjutan selama kehamilan yang sehat. Manajemen berat badan, termasuk aktivitas fisik teratur, penting untuk mencegah dan mengobati infertilitas, karena kelebihan berat badan dan obesitas dapat mengganggu kesuburan wanita dan mengurangi kemungkinan konsepsi spontan dan bahkan konsepsi dengan bantuan. Bukti menunjukkan bahwa aktivitas fisik

teratur yang moderat memengaruhi kesuburan dan hasil ART secara positif (Kogure GS et al., 2020 & Butt MS et al., 2023).

PCOS merupakan penyebab utama infertilitas anovulasi dan memengaruhi 12-18% wanita usia reproduksi. Olahraga teratur terbukti dapat mengurangi sebagian resistensi insulin yang ada pada PCOS. Olahraga teratur juga terbukti dapat memperbaiki frekuensi menstruasi dan ovulasi pada 60% wanita setelah intervensi olahraga intensitas sedang tiga kali seminggu selama 45 menit selama 12 minggu. Olahraga yang teratur sangat penting dilakukan, karena ketika olahraga berhenti di lakukan dapat membalikkan manfaat metabolisme dan berat badan yang diperoleh (Butt MS et al., 2023).

Berikut beberapa manfaat olahraga dalam menjaga fungsi reproduksi:

a. Meningkatkan kesuburan pada wanita

Olahraga teratur dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesuburan pada wanita. Penelitian oleh Gudmundsdottir et al. (2009) menemukan bahwa wanita yang rutin berolahraga memiliki peluang kesuburan yang lebih tinggi daripada wanita yang tidak aktif secara fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, mengurangi risiko gangguan hormonal, dan meningkatkan fungsi ovarium.

b. Meningkatkan kualitas sperma pada pria

Tidak hanya wanita, olahraga teratur juga memiliki manfaat pada fungsi reproduksi pria. Penelitian oleh Vaamonde et al. (2022) menunjukkan bahwa pria yang aktif secara fisik memiliki kualitas sperma yang lebih baik dibandingkan dengan pria yang jarang berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme, yang mendukung produksi sperma yang sehat.

c. Mengurangi risiko gangguan menstruasi

Olahraga teratur dapat membantu mengurangi risiko gangguan menstruasi pada wanita. Penelitian oleh Carmichael MA et al. (2021) menemukan bahwa wanita yang berpartisipasi dalam olahraga dengan intensitas sedang hingga tinggi cenderung mengalami siklus menstruasi yang lebih teratur dan kurang mengalami gangguan hormon.

d. Meningkatkan keseimbangan hormon

Olahraga teratur berperan dalam mengatur produksi hormon dalam tubuh. Penelitian oleh Ren & Xiao (2023) menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan produksi hormon serotonin, yang berperan dalam mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Hormon-hormon yang seimbang dalam tubuh memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi secara keseluruhan.

5. Stres atau Kesehatan Mental

Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan yang dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan reproduksi. Dalam kehidupan modern, banyak faktor yang dapat menyebabkan stres, seperti pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan masalah keuangan. Penting untuk memahami dampak stres terhadap kesehatan reproduksi dan bagaimana cara mengatasinya (Putri & Nikmatisni, 2022).

Stres merupakan reaksi fisik dan emosional yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap menekan. Proses ini melibatkan pelepasan hormon stres seperti kortisol yang dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem reproduksi. Wanita yang mengalami stres kronis cenderung memiliki masalah dalam ovulasi dan keseimbangan hormon, yang dapat mengganggu kesuburan (Phelan et al., 2021).

Dampak Stres terhadap Kesehatan Reproduksi

a. Gangguan Hormonal

Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Hormon kortisol yang dilepaskan saat stres dapat mengganggu produksi hormon reproduksi seperti estrogen dan testosteron. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur pada wanita dan menurunkan kualitas sperma pada pria (Dutta et al., 2022).

b. Masalah Menstruasi

Wanita yang mengalami stres berkepanjangan mungkin mengalami masalah menstruasi seperti siklus yang tidak teratur, nyeri haid yang lebih parah, atau bahkan tidak menstruasi sama sekali (amenore). Hal ini disebabkan oleh gangguan pada hipotalamus, bagian otak yang mengatur hormon reproduksi. Wanita melaporkan gangguan dalam siklus menstruasi mereka yang diketahui berhubungan dengan tekanan psikologis. Stres memiliki efek penghambatan pada sumbu gonad hipotalamus hipofisis (HPG). Hormon stres dan stres menghambat pelepasan GnRH dari hipotalamus, dan glukokortikoid menghambat pelepasan hormon luteinizing (LH) serta produksi estrogen dan progesteron oleh ovarium. Stres mengatur sumbu HPG melalui aktivasi jalur saraf simpatis hipotalamus yang menghasilkan pelepasan norepinefrin di ovarium (Ilmy et al., 2021).

Penelitian telah menunjukkan prevalensi PMS yang lebih tinggi pada wanita dengan tingkat stres psikososial yang tinggi. PMS dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan perempuan dan berhubungan dengan gangguan aktivitas sehari-hari dan gangguan kesehatan mental seperti

gangguan kecemasan, depresi pasca melahirkan dan perimenopause (Noelle O et al., 2019).

c. Menurunnya Libido

Stres juga dapat menurunkan libido atau gairah seksual baik pada pria maupun wanita. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dengan pasangan dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan (Manijeh et al., 2022).

d. Infertilitas

Stres yang tidak terkendali dapat menyebabkan kesulitan untuk hamil. Pada wanita, stres dapat mengganggu proses ovulasi, sementara pada pria, stres dapat menurunkan kualitas dan jumlah sperma³. Bahkan, stres juga dapat mempengaruhi hasil pengobatan infertilitas (Roozitalab S et al., 2021).

e. Kehamilan dan Keguguran

Bagi wanita hamil, stres berlebihan dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir dari ibu yang stres juga dapat mengalami masalah perkembangan (Roozitalab S et al., 2021).

Mengatasi Stres untuk Kesehatan Reproduksi

a. Olahraga Teratur

Olahraga adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres. Aktivitas fisik dapat membantu tubuh melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Cobalah untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan kaki, berlari, atau berenang.

b. Meditasi dan Relaksasi

Meditasi dan teknik relaksasi seperti yoga atau pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi, hasilnya akan terasa pada kesehatan mental dan fisik.

c. Pola Makan Sehat

Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu tubuh mengatasi stres. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, serta menghindari makanan yang tinggi gula dan lemak.

d. Istirahat yang Cukup

Tidur yang cukup sangat penting untuk mengelola stres. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam dan ciptakan rutinitas tidur yang baik.

e. Dukungan Sosial

Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental dapat membantu mengurangi stres. Dukungan sosial dapat memberikan rasa nyaman dan membantu kita merasa lebih tenang.

6. Lingkungan

Pencemaran lingkungan, termasuk polutan udara dan bahan kimia berbahaya, berdampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi manusia. Paparan polusi dapat menyebabkan kemandulan, keguguran, kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan janin. Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Bisphenol A (BPA) merupakan beberapa zat yang diketahui dapat merusak sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Pada wanita hamil, polusi udara dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan gangguan perkembangan janin. Di sisi lain, polusi juga memengaruhi kualitas sperma pada pria, yang berpotensi mengurangi kesuburannya. Selain itu, paparan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan gangguan endokrin yang memengaruhi keseimbangan hormon tubuh dan meningkatkan risiko kemandulan (Wiwik et. al, 2024).

Mekanisme dampak polusi terhadap kesehatan reproduksi terjadi melalui stres oksidatif yang merusak sel telur, sperma, dan jaringan serta organ terkait lainnya. Stres oksidatif ini dapat memengaruhi proses reproduksi di tingkat seluler, seperti penurunan kualitas gamet atau gangguan pada perkembangan janin. Selain itu, paparan zat kimia yang bersifat mengganggu endokrin dapat mengubah sistem pengaturan hormon tubuh, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya infertilitas, endometriosis, dan gangguan reproduksi lainnya (Shilpa et al., 2023 & Hanging Xu et al., 2022).

Untuk mengurangi risiko tersebut, langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memilih produk organik yang bebas pestisida berbahaya dan menghindari konsumsi ikan yang mengandung merkuri dalam kadar tinggi. Misalnya, bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian disarankan untuk menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Selain itu, penggunaan wadah plastik sebaiknya diganti dengan wadah kaca atau stainless steel yang lebih aman, terutama untuk menyimpan makanan yang akan dipanaskan. Pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan mengalihkan penggunaan energi ke sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, juga dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara yang membahayakan kesehatan reproduksi (Shilpa et al., 2023 & Fucic et al., 2021).

Namun, tantangan utama dalam mengurangi dampak polusi terhadap kesehatan reproduksi adalah tingginya kebiasaan merokok di kalangan remaja, khususnya di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah mengatur pengendalian tembakau, seperti pembatasan iklan dan kawasan tanpa asap rokok, prevalensi merokok di kalangan remaja diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pengendalian tembakau harus dilakukan secara multisektoral,

melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan industri, untuk menekan kebiasaan merokok yang membahayakan kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, pencemaran lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan reproduksi manusia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang meliputi perubahan pola konsumsi, pengendalian pencemaran udara, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan perubahan gaya hidup yang lebih sehat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kesehatan reproduksi bagi generasi mendatang (Dutta et al., 2022).

D. Simpulan

Pengaruh kesehatan reproduksi terhadap pola hidup adalah bahwa kesehatan reproduksi yang baik memiliki dampak langsung pada kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Ketika seseorang menjaga kesehatan reproduksinya, baik melalui pemeriksaan rutin, pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres, maka mereka lebih cenderung untuk memiliki pola hidup yang sehat. Sebaliknya, gangguan dalam kesehatan reproduksi, seperti masalah kesuburan, PMS, atau gangguan hormonal, dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosional, yang berujung pada penurunan kualitas hidup. Gangguan ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi, yang mengganggu keseimbangan pola hidup sehat. Dengan kata lain kesehatan reproduksi yang optimal berperan penting dalam mendukung pola hidup sehat, sedangkan gangguan reproduksi dapat menjadi hambatan bagi individu untuk menjalani hidup secara sehat dan bahagia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan reproduksi melalui pendidikan, kesadaran, dan perawatan yang tepat untuk menciptakan pola hidup yang lebih baik dan seimbang.

E. Referensi

- Audrey J . Gaskins ScD, Feiby L. Nassan ScD, MBBCh, Yu-Han Chiu MD, ScD, Mariel Arvizu MD, ScD, Paige L. Williams, PhD, vMyra G. Keller BSN, RNC, Irene Souter MD, Russ Hauser MD, ScD, Jorge E. Chavarro. (2019). EARTH Study Team. Dietary patterns and outcomes of assisted reproduction. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 220(6), 567-567. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.02.004>
- Avsar, T.S., McLeod, H. & Jackson, L. (2021). Health Outcomes Of Smoking During Pregnancy And The Postpartum Period: An Umbrella Review. *BMC Pregnancy Childbirth* 21, 254. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03729-1>

- Beroukhim, G., Esencan, E. & Seifer, D.B. Impact of sleep patterns upon female neuroendocrinology and reproductive outcomes: a comprehensive review. *Reprod Biol Endocrinol* 20, 16 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12958-022-00889-3>
- Butt, M.S., Saleem, J., Zakar, R. et al. (2023). Benefits of physical activity on reproductive health functions among polycystic ovarian syndrome women: a systematic review. *BMC Public Health* 23. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15730-8>
- Carmichael MA, Thomson RL, Moran LJ, Wycherley TP. (2021). The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes' Performance: A Narrative Review. *Int J Environ Res Public Health*. 18(4), 1667. <https://doi: 10.3390/ijerph18041667>.
- De Angelis, C., Nardone, A., Garifalos, F. Et Al. (2020). Smoke, Alcohol And Drug Addiction And Female Fertility. *Reprod Biol Endocrinol* , 18(21). <https://doi.org/10.1186/s12958-020-0567-7>
- D Abdulkhalikova, A. Sustarsic, Eda Vrtacnik Bokal. (2022). The Lifestyle Modifications and Endometrial Proteome Changes of Women With Polycystic Ovary Syndrome and Obesity. *Sec. Reproduction*, 13 (2022). <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.888460>
- Diana Vaamonde, Juan Manuel Garcia-Manso, Anthony C. Hackney,(2022). Effect of exercise and lifestyles on male reproductive potential. *Fertility. Pregnancy, and Wellness*, Elsevier, 2022, 131-147. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818309-0.00026-5>
- Dinu M, Pagliai G, Casini A, Sofi F.(2018). Mediterranean Diet And Multiple Health Outcomes: An Umbrella Review Of Meta-Analyses Of Observational Studies And Randomised Trials. *Eur J Clin Nutr*. 72, 30–43. <https://doi: 10.1038/Ejcn.2017.58>
- Dutta, Gorain, B., Choudhury, H. et al. (2022). Environmental and occupational exposure of metals and female reproductive health . *Environ Sci Pollut Res* 29, 62067–62092 <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16581-9>
- Erica Silvestris, Domenica Lovero, Raffaele Palmirotta. (2019). Nutrition and Female Fertility: An Interdependent Correlation. *Sec. Reproduction*. Volume 10 – 2019. <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00346>
- Esther Eisenberg, Richard S Legro, Michael P Diamond, Hao Huang, Louise M O'Brien, Yolanda R Smith, Christos Coutifaris, Karl R Hansen, Nanette Santoro, Heping Zhang. (2021). Sleep Habits of Women With Infertility, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 106(11), 4414 – 4426. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgab474>
- Fatma Indriani, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, Yuli Atfrikahani Harahap. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan

- Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal Of Science and Social Research*, 6 (1). <https://doi.org/10.54314/Jssr.V6i1.1150>
- Fucic, A, Duca, R.C, Galea, K.S, Maric, T, Garcia, K, Bloom, M.S, Andersen, H.R, Vena, J.E. (2021). Reproductive Health Risks Associated With Occupational And Environmental Exposure To Pesticides. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 18, 6576. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126576>
- Hajrija Mujovic & Ankica Sobot . (2024). Reproductive Rights In The Context Of Medical Law And Demographic Trends. *Medicine, Law & Society*, 17(2), 203-226. <https://doi.org/10.18690/mls.17.2.203-226.2024>
- Hanqing Xu, Yang Jia, Zhendong Sun, Jiahui Su, Qian S. Liu, Qunfang Zhou, Guibin Jiang, Environmental pollution, a hidden culprit for health issues. *Eco-Environment & Health*, 1(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.eehl.2022.04.003>.
- Ilmy Nurul Amalia, Johan Budhiana, Waqid Sanjaya. (2020). Hubungan Stres Dengan Gangguan Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri. *Jurnal Wacana Kesehatan*. 8(2). 75-82. <https://doi.org/10.52822/jwk.v8i2.526>
- Jumiati, Sarah Fitria, Ayu Rahmawati. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Dan Berat Badan Pada Pasangan Usia Subur Terhadap Kejadian Infertilitas. *Inovasi Riset Sains, Teknologi dan Kesehatan Dalam Menghadapi Era Pasca Vaksinasi*. 2(2021), 187-194, <https://doi.org/10.37859/sainstekes.v2i0.2899>
- Karayiannis D, Kontogianni MD, Mendorou C, Mastrominas M, Yiannakouris N. (2018) . Adherence to the Mediterranean diet and IVF success rate among non-obese women attempting fertility. *Hum Reproduc*. 33, 494–502. doi: 10.1093/humrep/dey003
- Kazemi M, McBreaity LE, Zello GA, Pierson RA, Gordon JJ, Serrao SB, et al.(2020). A Pulse-Based Diet And The Therapeutic Lifestyle Changes Diet In Combination With Health Counseling And Exercise Improve Health-Related Quality Of Life In Women With Polycystic Ovary Syndrome: Secondary Analysis Of A Randomized Controlled Trial. *J Psychosom Obstet Gynecol*, 41(2):144–53.
- Kervezee L, Shechter A, Boivin DB. (2018). Impact of Shift Work on the Circadian Timing System and Health in Women. *Sleep Medicine Clinics*. 13(3), 295-306. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2018.04.003>. PMID: 30098749.
- Kogure GS, Lopes IP, Ribeiro VB, Mendes MC, Kodato S, Furtado CLM, et al. (2020). The Effects Of Aerobic Physical Exercises On Body Image Among Women With Polycystic Ovary Syndrome. *J Affect Disord*. 202; 262, 350–8.
- Manijeh Dogani, Nayere Askari, Ali Kalantari-Hesari, Fatemeh Hosseini Rahbar. (2022). The Effects Of *P. Atlantica* As A Libido Booster And Sexual Enhancer On The Reproductive System Of Male Rats. *Journal of Traditional and*

- Mathias Abiodun Emokpae and Somieye Imaobong Brown. (2021). Effects of lifestyle factors on fertility: practical recommendations for modification. *Reproduction and Fertility*, 2 (10),13-26. <https://doi.org/10.1530/RAF-20-0046>
- Maqbool, Rubeena, Maqbool, Mudasir, Zehravi, Mehrukh and Ara, Irfat.(2021). Menstrual Distress In Females Of Reproductive Age: A Literature Review. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 32(2),11-17. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2021-0081>
- Minhal Mussawar, Ashley A. Balsom, Julia O. Totosy de Zepetnek, Jennifer L. Gordon. (2023). The Effect Of Physical Activity On Fertility: A Mini-Review. *F&S Reports*. 4(2), 150-158. <https://doi.org/10.1016/j.xfre.2023.04.005>
- Neneng Fitria Ningsih & Desri Nova H.(2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infertilitas Pada Wanita Usia Subur (WUS). *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 2(1),104-109.
- Nirmin F Juber, Abdishakur Abdulle, Abdulla AlJunaibi, Abdulla AlNaeemi, Amar Ahmad, Andrea Leinberger-Jabari, Ayesha S Al Dhaheri, Eiman AlZaabi, Fatma Al-Maskari, Fatme AlAnouti, Habiba Alsafar, Juma Alkaabi, Laila Abdel Wareth, Mai Aljaber, Marina Kazim, Michael Weitzman, Mohammad Al-Houqani, Mohammed Hag-Ali, Naima Oumeziane, Scott Sherman, Syed M Shah, Wael Almahmeed, Youssef Idaghdour, Tom Loney, Omar El-Shahawy & Raghib Ali. (2023). Association Between Self-Reported Polycystic Ovary Syndrome with Chronic Diseases Among Emiratis: A Cross-Sectional Analysis from the UAE Healthy Future Study. *International Journal of Women's Health* 15, 289-298. <http://doi.org/10.2147/IJWH.S272867>
- Noelle Ozimek, Karen Velez, Hannah Anvari, Lauren Butler, Kara N. Goldman, and Nicole C. Woitowich. (2022). Impact of Stress on Menstrual Cyclicity During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Survey Study. *Journal of Women's Health*, 31 (1). <https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0158>
- Omolaoye, .S., El Shahawy, O., Skosana, B.T. et al. The mutagenic effect of tobacco smoke on male fertility. *Environ Sci Pollut Res* 29, 62055–62066 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16331-x>
- Oostingh EC, Hall J, Koster MPH, Grace B, Jauniaux E, Steegers-Theunissen RPM. (2019). The impact of maternal lifestyle factors on periconception outcomes: a systematic review of observational studies. *Reproduc Biomed Online*. 38(6),77–94. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.09.015
- Permatasari, T.A.E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W. Inne Indraaryani S, Zahrofa H. (2021). The effect of nutrition and reproductive health education of pregnant women in Indonesia using quasi experimental study. *BMC*

- Pregnancy Childbirth 21(180). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03676-x>
- Phelan N, Behan LA and Owens L (2021) The Impact of the COVID-19 Pandemic on Women's Reproductive Health. *Front. Endocrinol.* 12, 642755 . [https://doi: 10.3389/fendo.2021.642755](https://doi.org/10.3389/fendo.2021.642755)
- Putri Ayuningtias Mahdang & Nikmatisni Arsad. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kesehatan Reproduksi Pekerja Wanita. *Jambura Journal Of Health Sciences and Research* 4(3), 869-879.
- Ren J, Xiao H. (2023). Exercise for Mental Well-Being: Exploring Neurobiological Advances and Intervention Effects in Depression. *Life (Basel)*. 13(7), 1505. [https://doi: 10.3390/life13071505](https://doi.org/10.3390/life13071505).
- Roozitalab S, Rahimzadeh M, Mirmajidi SR, Ataee M, Esmaelzadeh Saeieh S.(2021). The Relationship Between Infertility, Stress, and Quality of Life with Posttraumatic Stress Disorder in Infertile Women. *J Reprod Infertil.* 22(4), 282-288. [https://doi: 10.18502/jri.v22i4.7654](https://doi.org/10.18502/jri.v22i4.7654).
- Shilpa S, Shetty, Deepthi D, Harshitha S, Shipra Sonkusare, Prashanth B, Naik. Suchetha Kumari N. (2023). Environmental Pollutants And Their Effects On Human Health. *Heliyon* 9(9). 1-13.
- S.L. Gudmundsdottir, W.D. Flanders, L.B.(2009). Augestad, Physical Activity And Fertility In Women: The North-Trondelag Health Study. *Human Reproduction*, 24 (12), 3196–3204. <https://doi.org/10.1093/humrep/dep337>
- Wiwik Afridah, Fauziyatun Nisa, Tri Martiana . (2024). A Review Of The Impact Of Environmental Pollutions On Reproductive Health And Risk Mitigation Strategies. *journal Environ Qual Manage.* 20, 1–8.[https://doi:10.1002/tqem.22265](https://doi.org/10.1002/tqem.22265)
- Yujie Shang, Huifang Zhou, Minghui Hu, Hua Feng. (2020). Effect of Diet on Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 105(10), 3346–3360 <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa425>

F. Glosarium

WUS	= Wanita Usia Subur
ART	= Assisted reproductive technology
PCOS	= Polycystic Ovary Syndrome
HPV	= Human Papillomavirus
IVF	= in vitro fertilization
GnRH	= Gonadotropin-Releasing Hormone).
FSH	= Follicle-Stimulating Hormone)
LH	= Luteinizing Hormone)

CHAPTER 2

PERAN BIDAN DALAM MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Emilda AS, SST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial merupakan komponen yang sangat penting dalam kesehatan, termasuk dalam konteks kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan proses yang terjadi dalam sistem reproduksi manusia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada perempuan memberikan kontribusi yang signifikan, mencapai hingga 33% dari total beban penyakit yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Masa remaja sendiri adalah periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dimana individu pada tahap ini belum sepenuhnya mencapai kedewasaan mental dan sosial. Pada usia remaja, individu seringkali mengalami tekanan emosional serta sosial yang bertentangan satu sama lain, sehingga kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap beragam masalah kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi (Permatasari & Suprayitno, 2021).

Permasalahan terkait kesehatan reproduksi pada remaja memang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat jelas dari meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seksual (PMS), praktik seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, pelecehan seksual, serta tingginya angka kematian ibu. Fenomena ini banyak terjadi akibat kurangnya pemahaman di kalangan remaja mengenai perubahan fisik yang terjadi pada tubuh mereka, sehingga mereka merasa belum siap dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masa pubertas, seksualitas, dan kesehatan reproduksi. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan yang cukup, keterampilan yang diperlukan, serta nilai-nilai yang penting untuk mendukung mereka dalam menjaga kesehatan reproduksi secara tepat.

Pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun. Tahun ini juga akan menjadi momentum penting bagi Indonesia, karena

diperkirakan pada tahun tersebut sekitar 69% dari total populasi Indonesia akan berada pada usia produktif, sebuah situasi yang sangat menguntungkan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan (Kemenkes RI, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mulai merencanakan dan mengelola program-program yang dapat mendukung kesejahteraan remaja, agar proyeksi usia produktif ini dapat dikelola dengan baik. Remaja, yang menurut WHO adalah individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun, memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Masa remaja sendiri ditandai dengan perkembangan fungsi reproduksi yang semakin matang, yang menandakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Berbagai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama periode ini memerlukan adaptasi yang matang agar remaja dapat menghadapinya dengan bijaksana dan tepat (Heyrani et al., 2023).

Di kalangan pondok pesantren, pendidikan tentang kesehatan reproduksi sebenarnya bukanlah hal yang asing. Berbagai ayat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama yang berkaitan dengan topik ini telah diajarkan melalui kitab-kitab kuning, terutama dalam kajian fikih. Ilmu fikih memberikan panduan, petunjuk, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap dan membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi (Nurlaeli, 2020). Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan organ reproduksi adalah menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan vagina. Hal ini bertujuan untuk menjaga organ reproduksi tetap sehat, mencegah penyakit, serta menghindari masalah seperti keputihan (Muharrina et al., 2023). Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi di lingkungan pondok pesantren memiliki potensi besar untuk membantu remaja memahami berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang mereka hadapi, serta memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan mereka dengan baik dan benar.

B. Kesehatan Reproduksi di Era Modern

Kesehatan reproduksi merupakan bagian yang sangat penting dalam kesehatan secara keseluruhan, yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan sistem reproduksi sepanjang kehidupan seseorang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja adalah kelompok yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Berbagai studi menunjukkan bahwa remaja di Indonesia sering kali memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku berisiko tinggi, seperti hubungan seksual pranikah, kehamilan pada usia yang sangat muda, serta infeksi menular seksual (IMS).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Indonesia, angka kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi saat kehamilan dan persalinan masih cukup tinggi, yakni mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian tersebut. Namun, stigma sosial yang masih kental serta kurangnya dukungan dari keluarga maupun masyarakat sering kali membatasi akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan. Maka dari itu, dibutuhkan intervensi yang komprehensif, yang mencakup pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Kesehatan reproduksi tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga melibatkan hak untuk memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman, serta hak untuk mengatur jumlah anak sesuai dengan keinginan tanpa adanya hambatan. Selain itu, setiap individu juga berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai berbagai metode kontrasepsi agar mereka bisa memilih cara yang paling tepat untuk diri mereka. Layanan kesehatan reproduksi lainnya, seperti pelayanan antenatal (sebelum persalinan), proses persalinan, perawatan pasca-persalinan (nifas), serta layanan kesehatan untuk anak dan remaja, juga harus dijamin ketersediaannya dan kualitasnya (Rahayu et al., 2017).

Lingkup kesehatan reproduksi mencakup berbagai aspek yang melibatkan kehidupan, yang di antaranya mencakup hal-hal berikut: pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang harus mendapat perhatian khusus. Kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi pada saluran reproduksi, termasuk infeksi menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS yang dapat berisiko sangat tinggi jika tidak segera diatasi. Ketiga, pencegahan dan penanganan komplikasi yang mungkin timbul akibat aborsi. Keempat, kesehatan reproduksi remaja yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat rentannya kelompok usia ini terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Kelima, pencegahan dan penanganan masalah infertilitas atau ketidaksuburan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Keenam, kanker pada usia lanjut yang seringkali terlambat didiagnosis, padahal deteksi dini dapat memperbaiki prognosis. Ketujuh, berbagai aspek lain yang juga terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan masih banyak lagi yang perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah membuka peluang besar untuk mendukung peningkatan kesehatan reproduksi. Dengan adanya aplikasi kesehatan yang dapat digunakan di rumah, wanita kini dapat memantau kesehatan reproduksi

mereka secara mandiri. Sebagai contoh, ada aplikasi yang dapat membantu mencatat siklus menstruasi, memantau gejala kesehatan tertentu, serta mengenali tanda-tanda peringatan dini terkait gangguan kesehatan reproduksi. Selain itu, telemedicine juga semakin berkembang menjadi solusi yang sangat berharga, khususnya di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Konsultasi melalui telemedicine dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan pemeriksaan rutin yang sangat penting dalam mencegah masalah kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks, infeksi menular seksual, atau gangguan hormonal (Aini et al., 2022).

Namun demikian, kendala yang masih sering dihadapi adalah kurangnya informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, serta stigma sosial yang masih melilit topik ini. Hal ini menyebabkan remaja dan mahasiswa menjadi sangat rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, termasuk penyakit menular seksual. Secara global, diperkirakan lebih dari 500 juta orang dewasa muda mengalami infeksi menular seksual, sementara dua dari tujuh kasus HIV yang tercatat pada tahun 2019 terjadi pada remaja dan dewasa muda. Pada tahun 2020, lebih dari 1,5 juta remaja dan dewasa muda berusia antara 10 hingga 24 tahun meninggal dunia, dan sebagian besar dari kematian tersebut terkait langsung dengan masalah kesehatan reproduksi.

Paparan media yang semakin meluas tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang cukup sering kali memberikan dampak negatif bagi kemampuan remaja dalam membuat keputusan yang sehat terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Penelitian yang dilakukan di India menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang berisiko, yang pada gilirannya meningkatkan angka infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, serta aborsi. Di banyak negara berkembang, topik mengenai kesehatan reproduksi sering kali dianggap tabu, dan disangka akan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Namun, penyebaran informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi melalui berbagai media, baik daring (online) maupun luring (offline), menjadi salah satu solusi yang sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja. Media sosial, sebagai salah satu sarana komunikasi dan promosi kesehatan, telah memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Dengan informasi yang lebih tepat dan terkini, remaja dapat lebih mudah memahami risiko yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak aman dan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan mereka. Penggunaan media daring seperti internet juga menjadi sarana yang sangat

berguna dalam memperbaiki perilaku reproduksi masyarakat melalui promosi kesehatan berbasis teknologi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, faktor internal yang mencakup pendidikan yang diterima serta pengalaman individu yang bersangkutan. Kedua, faktor eksternal yang meliputi pengaruh budaya, serta ketersediaan dan akses informasi yang berkualitas. Dalam era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi kesehatan melalui perangkat seperti tablet atau smartphone. Website dan media daring lainnya menjadi sumber yang sangat efektif dalam mendukung pendidikan kesehatan reproduksi secara lebih luas dan efisien (Leonita & Jalinus, 2018).

C. Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi Remaja

Masa remaja adalah fase penting dalam kehidupan setiap individu, yang ditandai dengan perubahan besar dalam berbagai aspek fisik, emosional, dan psikososial. Pada periode ini, remaja mulai mengeksplorasi identitas seksual mereka, yang menjadikan kesehatan reproduksi remaja sebagai isu yang sangat krusial dan mendasar. Hal ini berhubungan langsung dengan kualitas hidup mereka di masa depan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, Indonesia memiliki populasi remaja berusia antara 10 hingga 24 tahun sebanyak 64 juta orang, yang mencakup sekitar 27,6% dari total populasi negara ini. Mengingat jumlah remaja yang sangat besar ini, memastikan mereka tumbuh dengan sehat, baik secara fisik maupun mental, adalah langkah yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus.

Namun, meskipun jumlahnya besar, banyak remaja di Indonesia yang menghadapi berbagai masalah kesehatan reproduksi yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Beberapa masalah yang paling sering dialami oleh remaja termasuk seksualitas, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba (napza), serta rendahnya pengetahuan mereka mengenai kesehatan reproduksi yang pada akhirnya berdampak pada perilaku mereka. Berdasarkan data BKKBN tahun 2010, sekitar 34,5% remaja laki-laki dan 33,3% remaja perempuan mulai berpacaran pada usia 15 tahun. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi pada usia yang lebih dini. Selain itu, angka pernikahan dini yang masih tinggi, dengan rata-rata usia pernikahan perempuan yang mencapai sekitar 19,8 tahun, semakin memperburuk permasalahan ini.

Pada masa remaja, individu belum sepenuhnya matang dalam aspek fisik, emosional, dan psikologis untuk dapat menghadapi dampak dari hubungan seksual

yang tidak sehat atau perilaku seksual berisiko. Oleh karena itu, mereka memerlukan informasi yang tepat dan pendampingan yang baik agar dapat menghindari masalah kesehatan reproduksi. Salah satu langkah yang sangat penting adalah dengan meningkatkan promosi serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi remaja. Ini mencakup penguatan pendidikan seksualitas, penyuluhan mengenai penghindaran perilaku seks bebas, dan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi.

Meningkatkan upaya untuk mempromosikan dan mencegah masalah kesehatan reproduksi remaja sangatlah penting. Masa remaja ditandai dengan perubahan tubuh yang sangat pesat, serta perkembangan fisik yang memungkinkan remaja untuk melakukan fungsi reproduksi meskipun secara emosional mereka belum sepenuhnya siap untuk menanggung konsekuensi dari proses tersebut. Oleh karena itu, remaja sangat membutuhkan informasi yang cukup, penyuluhan yang efektif, konseling, dan juga layanan medis yang lebih baik untuk membantu mereka memahami dan mengelola kesehatan reproduksi mereka dengan cara yang bijaksana dan sehat.

Seiring dengan perkembangan fisik yang pesat, remaja juga mengalami perubahan psikososial yang sangat memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian Iskandarsyah (2006), masa remaja dapat dibagi menjadi tiga tahap perkembangan psikososial dan seksual yang sangat menentukan pola pikir dan perilaku mereka:

1. Masa Remaja Awal/Dini (10–13 Tahun): Pada tahap ini, remaja mulai merasa lebih dekat dengan teman sebaya dan mulai mencari kebebasan dari pengaruh orang tua. Mereka mulai menyadari perubahan fisik dalam tubuh mereka, seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan perubahan suara pada laki-laki. Di usia ini, remaja juga mulai merasakan perasaan yang lebih intens terhadap tubuh mereka dan mulai memperhatikan identitas diri.
2. Masa Remaja Pertengahan (14–16 Tahun): Pada tahap ini, remaja cenderung mencari identitas diri dan mulai tertarik pada lawan jenis. Mereka sering kali merasa jatuh cinta, dan perasaan ini berkembang seiring dengan kemampuan mereka untuk berpikir lebih abstrak. Pada usia ini, remaja mulai berkhayal tentang seksualitas dan hubungan romantis, yang dapat mempengaruhi pola perilaku mereka dalam berinteraksi dengan lawan jenis.
3. Masa Remaja Lanjut (17–19 Tahun): Pada tahap akhir remaja, individu mulai lebih selektif dalam memilih teman sebaya dan menunjukkan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan jalur hidup mereka. Di usia ini, mereka sudah mulai lebih matang dalam mengekspresikan perasaan cinta dan membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab terkait hubungan interpersonal dan seksual.

Kemampuan berpikir mereka semakin berkembang, sehingga mereka mampu membuat keputusan dengan pertimbangan yang lebih matang.

Di antara berbagai masalah kesehatan reproduksi yang paling mendesak di kalangan remaja adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering kali berujung pada aborsi yang tidak aman, serta penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS. Selain berisiko bagi kesehatan fisik, masalah-masalah ini juga dapat berdampak buruk pada kondisi mental, emosional, dan sosial remaja, yang berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka serta masyarakat secara keseluruhan.

Sebagian besar remaja masih kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan data Riskesdas 2010, hanya sekitar 25,1% remaja di Indonesia yang pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Kekurangan informasi ini sangat mempengaruhi perilaku mereka, seperti terlibat dalam hubungan seks pranikah yang berisiko tinggi. Selain itu, sekitar 15,9% remaja laki-laki dan 10,1% remaja perempuan yang sudah berusia 18 tahun dilaporkan pernah melakukan hubungan seksual, sementara sekitar 771 dari 10.000 remaja berusia 18–19 tahun mengalami kehamilan. Salah satu alasan utama di balik tingginya angka ini adalah minimnya pengetahuan mengenai konsekuensi dari hubungan seksual yang tidak aman dan rendahnya tingkat pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Pendidikan seksualitas yang memadai bagi remaja sangat penting untuk mencegah perilaku berisiko dan membantu mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kehidupan seksual dan reproduksi mereka. Pendidikan ini juga sangat penting untuk mencegah kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, serta penularan penyakit menular seksual. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tubuh mereka, cara melindungi diri dari penyakit, serta bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan pasangan, remaja dapat lebih siap menghadapi kehidupan seksual dan reproduksi mereka.

Salah satu upaya yang sangat penting dalam hal ini adalah melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang menyeluruh. Program ini perlu dilakukan di berbagai tingkat, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga. Penyuluhan yang dilakukan dengan cara yang efektif dapat membantu remaja memahami isu-isu penting terkait kesehatan reproduksi, seksualitas, dan pilihan hidup yang sehat. Penyuluhan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta pemahaman remaja agar mereka dapat lebih mudah menerima informasi yang diberikan kepada mereka (Heyrani, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, peran bidan sangatlah penting dan tak bisa dianggap remeh. Bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk memberikan informasi, penyuluhan, serta konseling kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 900/Menkes/SK/2002, bidan adalah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Bidan juga berfungsi sebagai konselor bagi remaja yang membutuhkan informasi atau bantuan dalam mengatasi masalah kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Peran bidan sangat vital dalam memberikan penyuluhan kepada remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi mereka, cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta penghindaran perilaku seks bebas yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Bidan juga bertugas memberikan edukasi tentang kontrasepsi, deteksi dini penyakit, serta bagaimana cara mengatasi berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya yang mungkin dihadapi oleh remaja.

Sebagai konselor, bidan diharapkan dapat menjadi tempat yang aman bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi terkait kesehatan reproduksi. Dengan pengetahuan yang memadai serta kemampuan komunikasi yang baik, bidan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada remaja, serta membantu mereka membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Pendekatan yang penuh pengertian dan tanpa penghakiman akan sangat membantu remaja dalam mencari solusi untuk masalah mereka.

Penting untuk diingat bahwa masalah kesehatan reproduksi tidak hanya berdampak pada remaja perempuan, tetapi juga pada remaja laki-laki. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh bidan harus inklusif dan melibatkan kedua gender dalam diskusi serta edukasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, peran bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan untuk perempuan, tetapi juga mencakup pelayanan untuk laki-laki, yang pada akhirnya akan membantu menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Novita et al. (2021) mengemukakan beberapa langkah untuk melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kesehatan reproduksi mereka, seperti memberikan informasi yang lengkap, memberikan pandangan yang jelas tentang konsekuensi dari pilihan yang mereka buat, dan mendukung mereka dalam setiap keputusan yang diambil.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diluncurkan oleh BKKBN bertujuan untuk menunda pernikahan dini dengan memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang dapat dialami oleh remaja yang menikah pada usia yang sangat muda. Usia pernikahan yang disarankan dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010 adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ini dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik, emosional, dan sosial untuk memulai kehidupan berkeluarga yang sehat.

Pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh bidan dalam berbagai setting, seperti sekolah, klinik, atau rumah sakit, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi. Melalui program pendidikan yang tepat, diharapkan remaja dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan tubuh mereka dan mampu membuat keputusan yang baik mengenai seksualitas serta hubungan interpersonal mereka.

Dengan berbagai peran yang dimiliki oleh bidan—mulai dari penyuluhan, konseling, hingga pelayanan medis—di harapkan remaja Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik tetapi juga kesejahteraan emosional dan psikososial mereka. Secara keseluruhan, peran bidan dalam menyediakan informasi, memberikan edukasi, serta mendukung remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka sangatlah penting. Bidan berfungsi sebagai konselor yang dapat memberikan arahan serta bantuan kepada remaja yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi. Dengan peran aktif dari bidan, diharapkan remaja akan lebih siap dalam membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

D. Implementasi Praktis

1. Keberadaan Remaja dan Kesehatan Remaja dalam Konteks Kebijakan Global

Saat ini, remaja menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian utama dalam kebijakan global, terutama seiring dengan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Dengan jumlah populasi remaja yang mencapai sekitar 1,2 miliar jiwa dari total populasi dunia yang berjumlah 7,6 miliar, kelompok ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam pembangunan global. Berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh remaja sangat beragam, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah kesehatan jiwa, hingga cedera. Selain itu, ada pula isu-isu lain yang mengancam kesejahteraan remaja, seperti kecukupan gizi, kesehatan

reproduksi, pernikahan usia anak, kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, serta kekerasan dan pelecehan seksual.

Berbagai masalah kesehatan ini seringkali dipengaruhi oleh perilaku berisiko yang dilakukan oleh remaja, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba seperti ganja, serta rendahnya tingkat aktivitas fisik yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan pembinaan kesehatan remaja sebagai bagian dari program prioritas nasional. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan merancang kebijakan kesehatan yang efektif dan tepat sasaran. Kebijakan kesehatan ini dapat dipahami sebagai rangkaian konsep, prinsip, ketentuan utama, dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik untuk mencapai keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa adanya keluhan atau tanda-tanda penyakit. Tujuan utama dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan berbagai layanan kesehatan yang meliputi pencegahan (preventive), pemeliharaan kesehatan (promotif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), serta perlindungan bagi kelompok yang rentan, termasuk remaja. Hayrani (2023) memberikan beberapa langkah bijak yang dapat diambil untuk mempertahankan hak-hak reproduksi remaja, antara lain: memperkuat aspek spiritual sebagai upaya pencegahan tindakan yang dapat merugikan masa depan, menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif untuk membantu remaja membuat keputusan yang bijaksana mengenai kesehatan reproduksi mereka, menghindari tekanan atau pemaksaan dari teman atau pasangan, serta mendorong remaja untuk bertanya kepada tenaga medis yang kompeten ketika menghadapi kebingungan atau pertanyaan mengenai hak-hak reproduksi mereka.

2. Program Kesehatan Remaja di Indonesia: Pendekatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Pada tahun 2003, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Program Kesehatan Remaja dengan pendekatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Program ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya profesional tetapi juga menyenangkan, dengan penerimaan yang hangat terhadap remaja, menghargai hak privasi mereka, serta menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan kesehatan yang khas pada kelompok usia tersebut. Tujuan dari program PKPR adalah untuk menyediakan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi remaja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka.

3. Implementasi Program PKPR dan Faktor yang Mempengaruhinya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk program PKPR, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, terdapat sejumlah variabel yang berperan dalam menentukan sukses atau gagalnya kebijakan tersebut. Beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan adalah: (1) standar dan sasaran kebijakan yang jelas, (2) ketersediaan sumber daya yang memadai, (3) karakteristik badan pelaksana yang terlibat dalam program, (4) sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan, (5) kualitas komunikasi antar organisasi atau lembaga terkait, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di lapangan. Meskipun program PKPR telah diterapkan di sejumlah puskesmas, hasilnya tetap bervariasi. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, hanya sekitar 45,43% dari 876 puskesmas yang berhasil menjalankan program PKPR. Bahkan, di Kabupaten Magelang, pencapaian program PKPR terbilang rendah, hanya sekitar 13,79% dari jumlah puskesmas yang ada, meskipun ada 92.525 remaja yang menjadi sasaran, namun hanya 23.990 remaja yang berhasil menerima layanan kesehatan.

4. Sumber Daya Manusia dalam Implementasi PKPR

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Muntiran I terdiri dari bidan puskesmas, bidan desa, serta penanggung jawab Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Meskipun jumlah SDM yang terlibat cukup banyak, mereka harus menjalankan berbagai tugas lainnya di luar program PKPR, yang mengakibatkan kurangnya fokus dan efektivitas dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa staf yang terlibat dalam program PKPR sering kali merangkap pekerjaan lain, yang berujung pada pengurangan kualitas layanan yang dapat diberikan kepada remaja. Hal ini menandakan pentingnya meningkatkan jumlah SDM yang terlatih dan memastikan mereka dapat bekerja dengan fokus penuh dalam menjalankan program ini.

E. Simpulan

Remaja merupakan kelompok yang sangat penting dalam kebijakan kesehatan global, mengingat populasi mereka yang besar dan berbagai masalah kesehatan yang mereka hadapi. Isu-isu seperti perilaku berisiko, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, serta kekerasan dan penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Oleh karena itu, program kesehatan remaja, seperti Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR), memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan mereka melalui layanan yang komprehensif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan remaja.

Namun, implementasi program PKPR di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang dan Puskesmas Muntilan, masih menghadapi tantangan besar. Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta kurangnya sasaran yang jelas dan terukur. Meskipun Puskesmas Muntilan telah menjalankan program ini sejak 2010, pencapaiannya masih rendah karena adanya keterbatasan dalam jumlah petugas terlatih dan fokus yang terpecah dengan tugas lain.

Keberhasilan program PKPR sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, karakteristik badan pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja program ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan SDM yang terlatih, penyediaan anggaran yang memadai, dan perencanaan yang lebih terstruktur dengan target yang jelas. Hanya dengan cara ini, program kesehatan remaja dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial remaja di Indonesia.

F. Referensi

- A'ini, Z. F., Alfy, Z. R., & Trista, R. T. (2022). Penyuluhan Pentingnya Deteksi Dini Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Menggunakan Teknologi. *Publikasi Pengabdian Masyarakat Komputer dan Teknologi (PUNDIMASKOT)*, 1(2), 101-106.
- Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, E., & Nurbaeti, N. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2067-2074.
- Anisah, S. N. (2020). Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 4), 846-854.
- Fatkhiyah, N., Masturoh, M., & Atmoko, D. (2020). Edukasi kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 4(1), 84-89.
- Fitria, A., Safitri, J., & Nisa, H. (2023). Hubungan Akses Informasi Kesehatan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 8(2), 180-188.
- Ghaissani, F. Z. (2023). *Hubungan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Terhadap Pengetahuan Tentang Kehamilan Pada Remaja Di Desa Jatilawang Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Heyrani, H., Latuconsina, N. A., Yuliati, L., Rudhiati, F., Lailani, M., Yanthi, D., ... & Widayati, K. (2023). Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Iskandarsyah, A. 2006. Remaja dan Permasalahannya: Perspektif Psikologi Terhadap Permasalahan Remaja dalam Bidang Pendidikan. Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran.
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran media sosial dalam upaya promosi kesehatan: Tinjauan literatur. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi*, 18(2), 25-34.
- Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & Nugraheni, S. A. (2017). Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan (studi pada remaja di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 332-340.
- Muharrina, C. R., Yustendi, D., Sarah, S., Herika, L., & Ramadhan, F. (2023). Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 5(1), 26-29.
- Novita, R., Herayono, F. & Drama, I. Y. (2021). Kesehatan Reproduksi Sepanjang Daur Hidup Wanita.
- Nurlaeli, H. (2020, February). Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja santri putri Pondok Pesantren Watu Ringkel Darussalam-Karangpucung. In *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 204-215).
- Permatasari, D., & Suprayitno, E. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *Jurnal Empathy Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8-12.
- Rahayu, A., Noor, M. S., Yulidasari, F., Rahman, F., & Putri, A. O. (2017). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia.
- Winatasari, D. (2021). Peran Bidan Puskesmas Dalam Pelaksanaan Konseling Remaja Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Akhir Di Puskesmas Bancak. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 6(1), 43-55.

G. Glosarium

IMS= Infeksi Menular Seksual
 KIE= Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
 KTD= Kehamilan yang Tidak Diinginkan
 PKPR= Pendekatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
 PMS= Penyakit Menular Seksual
 PUP= Program Pendewasaan Usia Perkawinan
 SDM= Sumber Daya Manusia
 UKS= Unit Kesehatan Sekolah

CHAPTER 3

PERAWATAN KESEHATAN SEKSUAL PADA IBU PASCA PERSALINAN

Dr. Irnawati, S.SiT., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem reproduksi dan organ seksual wanita mengalami beberapa perubahan selama masa kehamilan dan persalinan. Perubahan fisiologis ini terjadi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan tubuh ibu beradaptasi. Hormon-hormon yang berpengaruh selama masa kehamilan dan persalinan diantaranya hormon progesteron, estrogen, HCG, oksitosin dan prolaktin. Hormon-hormon tersebut yang berfungsi untuk menjaga otot-otot uterus mempertahankan kehamilan, membuat uterus berkontraksi pada proses persalinan, membantu memproduksi ASI dan menjaga keseimbangan elektrolit tubuh ibu (Clark-Patterson, Domingo, and Miller 2022).

Perubahan fisiologis tubuh perempuan terutama organ reproduksi juga terjadi selama masa hamil dan bersalin. Pada masa kehamilan payudara membesar dan menjadi lebih sensitif pada akhir kehamilan dan diikuti oleh produksi ASI setelah persalinan. Serviks menjadi lebih lembut pada masa kehamilan dan akan kembali ke keadaan semula setelah persalinan, namun tidak menjadi tidak seperti sebelum kehamilan. Vagina dan vulva mengalami hipervaskularisasi selama kehamilan, pada persalinan normal, bisa mengalami robekan atau peregangan sehingga memerlukan waktu untuk Kembali seperti kondisi sebelum hamil (Boland et al. 2020).

Perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh perempuan pasca salin mengakibatkan menurunnya intensitas hubungan seksual. Intensitas hubungan seksual yang menurun terutama dirasakan oleh perempuan yang menyusui. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kadar estrogen, sehingga vagina menjadi atrofi, dan kadar androgen menurun sehingga mengakibatkan gangguan libido. Siklus tersebut menyebabkan terjadinya dispareunia, sehingga perempuan pasca salin menjadi enggan untuk melakukan hubungan seksual. Selain perubahan fisiologis pada tubuh, perempuan pasca salin dan pasangannya juga menjalani proses adaptasi psikologis periode pascapersalinan. Pasangan dihadapkan dengan berbagai permasalahan psikososial terutama dalam hal pengasuhan bayi (O'Malley, Higgins, and Smith 2023).

Kesehatan seksual merupakan landasan kesejahteraan bagi semua individu, pasangan, dan keluarga. Terpenuhinya kesehatan seksual yang baik pada setiap individu, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kesehatan seksual memberikan berpengaruh pada kesehatan fisik. Terpenuhinya kebutuhan seksual dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, kesehatan seksual juga berkontribusi pada kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan. Kesehatan seksual telah juga diyakini dapat meningkatkan harga diri, menurunkan depresi, dan peningkatan libido. Dampak positif dari kesehatan seksual dapat meningkatkan kualitas tidur, memperkuat bonding antar pasangan, dan mampu mengurangi rasa nyeri melalui cara alami (Almuqahwi et al. 2023).

Kesehatan seksual pada ibu pasca persalinan merupakan permasalahan penting yang harus diberikan diperhatikan, namun masih sering terabaikan baik oleh tenaga kesehatan pemberi asuhan maupun oleh keluarga/pasangan. Maslow, (1954) menyebutkan seksual merupakan kebutuhan biologis yang mendasar pada setiap manusia. Kebutuhan biologis ini sejajar dengan kebutuhan fisik paling mendominasi kebutuhan manusia sama seperti oksigen, makanan dan air. Sehingga sudah sepatutnya perawatan kesehatan seksual pada ibu pasca bersalin harus diberikan dengan kualitas yang sama dengan perawatan kesehatan lainnya.

B. Kesehatan Seksual

WHO (2017), mendefinisikan kesehatan seksual berupa keadaan sejahtera fisik, emosional, mental dan sosial yang berhubungan dengan seksualitas. Kondisi Kesehatan seksual tidak hanya terbebas dari penyakit, disfungsi atau kelemahan. Kesehatan seksual memerlukan pendekatan yang positif dan penuh hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual, serta kesempatan untuk mendapatkan pengalaman seksual yang menyenangkan dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan, agar kesehatan seksual dapat tercapai dan terpelihara, hak-hak seksual setiap orang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Kata sex menunjukkan jenis kelamin, mengacu pada ciri-ciri biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan atau laki-laki. Seksualitas adalah elemen utama yang sangat penting dari keberadaan manusia sepanjang hidup dan mencakup jenis kelamin, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, keinginan, keyakinan, sikap, nilai, perilaku, praktik, peran dan hubungan. Meskipun seksualitas dapat mencakup semua dimensi ini, tidak semuanya selalu dialami atau diungkapkan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi

faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, agama dan spiritual (WHO 2017).

Sexual rights atau hak sesual merupakan hak asasi manusia berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Hak seksual adalah bagian dari hak asasi manusia yang sudah diakui dalam berbagai dokumen internasional dan nasional, serta dalam pengetahuan ilmiah tentang kesehatan seksual. Hak seksual mencakup hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan seksual yang komprehensif, hak untuk memilih pasangan dan menikah, hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas. WHO juga menekankan pentingnya perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan stigma yang berkaitan dengan seksualitas. Hak seksual juga mencakup hak untuk privasi dan kerahasiaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi.

C. Perawatan Kesehatan Seksual

Banyak tenaga Kesehatan masih memandang seksualitas hanya sebagai sarana untuk hamil agar seorang perempuan untuk dapat hamil. Perawatan difokuskan pada kesehatan fisik dan psikologis perempuan selama kehamilan dan pasca persalinan. Hasil penelitian Almuqahwi et al (2023), menunjukkan pentingnya kesehatan seksual bagi kesejahteraan fisik dan mental.

Geuens, Mivšek, and Gianotten (2023) menjelaskan bahwa seksualitas merupakan aspek yang sangat penting dari kualitas hidup dan hubungan antar individu. Proses kehamilan dapat mengubah fungsi seksual seorang perempuan. Pada sebagian perempuan merasakan penurunan libido, dan pada sebagian lagi akan meningkat. Masa hamil juga mengakibatkan perubahan orgasme. Hampir semua laki-laki calon ayah mengalami perubahan emosional dan fisik. Terjadi perubahan pada struktur hormon gonadnya, sehingga pola seksualitas berubah selama kehamilan istrinya. Kehamilan pertama sangat berdampak pada romantisme dan hubungan seksual calon orang tua. Masalah akan timbul jika kedua pasangan suami istri tidak berhasil menghadapi perubahan yang terjadi.

Ada istilah pada masyarakat "bersalin berarti perpisahan!". Beberapa pasangan muda mengalami masalah seksual pasca persalinan dan berdampak serius pada hubungan. Lima persen pasangan muda bercerai dalam waktu 2 tahun setelah kelahiran pertama, bila bayi lahir dengan berat rendah, persentase ini dapat meningkat hingga lima belas persen. Perceraian disebabkan oleh masalah seksual dan keintiman (Perez 2020).

Banyak tenaga kesehatan yang beranggapan seksualitas adalah masalah yang sensitif. Sehingga masalah kesehatan seksual sangat jarang menjadi topik saat

tenaga kesehatan memberikan komunikasi, informasi dan edukasi. Secara global WHO mengakui kesehatan seksual sebagai bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. WHO telah menetapkan parameter kesehatan seksual. Beberapa diantara parameter tersebut adalah: kemampuan pria dan wanita untuk memperoleh kesehatan seksual; tersedianya informasi yang komprehensif dan berkualitas baik tentang kesehatan seksual; pengetahuan tentang risiko dan konsekuensi buruk dari aktivitas seksual tanpa pengaman; kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan seksual; dan hidup di lingkungan yang mendukung dan mempromosikan kesehatan seksual.

D. Permasalahan Kesehatan Seksual Pada Ibu Pasca Persalinan

Kelahiran bayi, bagi banyak orang, merupakan momen yang menggembirakan; namun, selama bulan-bulan berikutnya, perubahan signifikan sering terjadi dalam hubungan pasangan. Bagi banyak pasangan, selama 12 bulan pertama setelah kelahiran, hubungan intim mereka berubah, khususnya, aspek hubungan seksual. Ibu merasakan kelelahan ekstrem, beradaptasi dengan peran baru sebagai orang tua, perawatan bayi, dan kekhawatiran atas kesejahteraan bayi. Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi hubungan suami istri, dengan hubungan seksual mereka sering kali menurun dari daftar prioritas mereka.

Banyak pasangan menormalisasi kondisi hubungan seksual yang mengalami penurunan. Selama masa antenatal, tenaga kesehatan sangat jarang menyampaikan, jika kondisi ini akan terjadi pada saat pasca bersalin nanti. Calon orang tua harus diberi tahu tentang kemungkinan perubahan pada hubungan intim dan seksual mereka, sehingga mereka menyadari dan siap menghadapinya jika terjadi. Penting juga bagi pasangan untuk diberikan informasi praktis berbasis bukti, berbasis penelitian jika memungkinkan, tentang kesehatan seksual pascapersalinan, termasuk strategi untuk mempertahankan hubungan intim yang memuaskan dengan pasangan mereka selama tahun pertama pasca persalinan.

Perubahan fisik, hormonal dan psikologis pada ibu masa pasca persalinan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seksual. Hampir semua mengalami gangguan kesehatan seksual pasca bersalin. Terganggunya kesehatan seksual umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: perubahan fisik, faktor psikologis dan hubungan psikososial (Graziottin, Di Simone, and Guarano 2024).

1. Perubahan Fisik

Sistem reproduksi wanita dirancang secara evolusioner untuk kehamilan dan persalinan. Meskipun proses reproduksi bersifat fisiologis, kehamilan menyebabkan banyak perubahan dalam tubuh yang dianggap patologis pada kondisi tertentu. Kondisi patologis disebabkan oleh proses adaptasi

kardiovaskular, pernapasan, hormonal, gastrointestinal, dan homeostatis kehamilan memiliki ciri-ciri yang sama dengan kondisi seperti gagal hati atau sepsis. Pada masa hamil dapat terjadi peningkatan curah jantung, penurunan resistensi vaskular sistemik, peningkatan aktivitas sistem reninangiotensin dan retensi cairan interstisial. Pada kondisi tertentu dapat menyebabkan nyeri somatik dan atau viseral. Kompresi saraf dapat disebabkan oleh cairan yang tertahan di ruang sempit yang mengakibatkan misalnya sindrom terowongan karpal (CTS). Perubahan fisiologisstruktur anatomi di daerah vertebra dan torako-abdominal menyebabkan nyeri punggung, penyakit refluks gastroesofageal (GERD), konstipasi, dan dapat terjadi pemisahan simfisis pubis. Perubahan-perubahan ini menyebabkan gejala ketidaknyamanan fisik yang umum terjadi selama kehamilan, seperti kelelahan, mual, kram, nyeri punggung, dan dalam beberapa kasus, menambah nyeri yang sudah ada sebelumnya di daerah yang sama. Persalinan kemudian semakin menambah nyeri akut yang parah pada perubahan-perubahan tersebut (Horvath, Kloesel, and Cross 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 1.123 ibu yang melakukan pemeriksaan kesehatan 9–12 bulan setelah melahirkan, lebih dari enam puluh sembilan persen responden mengalami masalah yang memengaruhi kesehatan dan 37% melaporkan nyeri sedang atau berat pada punggung, nyeri perut, nyeri vagina, atau dispareunia. Sebagian ibu mengalami nyeri pasca persalinan persisten karena adaptasi fisiologis dan patologis terhadap keadaan kehamilan. Sebagian kasus disebabkan oleh intervensi operatif dan farmakologis selama persalinan (Vaamonde, du Plessis, and Agarwal 2016).

Perubahan fisik yang paling sering dirasakan oleh perempuan pasca persalinan adalah dyspareunia. Dispareunia adalah adalah nyeri pada organ genitalia, terjadi saat berhubungan seksual atau setelahnya. Nyeri terjadi setiap melakukan hubungan seksual atau hanya pada saat tertentu saja. Nyeri dispareunia bersifat tajam, panas, terkadang dirasakan seperti kram saat menstruasi. Nyeri dapat terjadi pada organ genital eksterna, seperti vulva, dapat juga terjadi pada organ genitalia interna seperti vagina atau vesica urinaria. Dispareunia yang dirasakan perempuan pasca persalin paling sering disebabkan oleh tindakan episiotomi (Howard et al. 2024). Penyebab timbulnya dyspareunia post episiotomy pasca salin disebabkan oleh cicatrix atau skar bekas luka episiotomy. Rasa sakit sampai dengan iritasi terjadi saat adanya tekanan selama aktifitas seksual. Jaringan luka yang sulit terhubung dengan sempurna akan mengurangi fleksibilitas dan menimbulkan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual.

Luka episiotomi yang tidak dirawat dengan baik berisiko infeksi, menambah rasa sakit dan memperlama waktu pemulihan. Jaringan bekas luka episiotomi akan mengurangi pelumasan alami di area perineum, sehingga vulva menjadi kering dan terjadi iritasi selama hubungan seksual (Wood et al. 2022). Metode persalinan, seperti persalinan spontan per vaginam atau persalinan dengan tindakan operasi, juga dapat mempengaruhi kesehatan seksual, meskipun pengaruhnya tidak begitu signifikan. Prosedur Tindakan persalinan seksio kaesaria juga memiliki risiko. Risiko yang terjadi seperti rasa sakit di area bekas luka operasi dan masa pemulihan yang lebih lama dibandingkan dengan persalinan melalui vaginam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang pasca tindakan seksio kaisaria juga mengalami gangguan libido namun hasil uji statistik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (Pratama 2020).

Selain dispareunia yang disebabkan oleh cicatrix episiotomi maupun seksio sesaria, perubahan fisik pasca salin yang mengakibatkan gangguan kesehatan kesehatan seksual adalah kelelahan. Kelelahan fisik dan kurangnya waktu tidur karena merawat bayi baru lahir dapat mengurangi libido. Turunnya libido akibat kelelahan fisik tidak hanya dirasakan oleh laki-laki, namun juga sangat sering dialami oleh perempuan (Sabola et al. 2020).

Terjadinya perubahan hormonal yang terjadi sejak kehamilan sampai dengan persalinan dan proses menyusui menjadi salah satu faktor fisik yang berdampak pada kesehatan seksual. Selama kehamilan, kadar hormon estrogen dan progesteron meningkat secara drastis. Kedua hormon ini dapat menyebabkan peningkatan aliran darah organ reproduksi seperti payudara dan organ genitalia, yang bisa meningkatkan libido. Namun, dampak dari tingginya kadar hormon progesterone menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan seperti mual, muntah, dan kelelahan. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan turunnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Pasca persalinan, hormon estrogen dan progesteron yang sangat tinggi pada masa kehamilan menjadi turun drastis. Tubuh perempuan post partum mulai beradaptasi kembali ke kondisi sebelum hamil. Adanya bekas luka episiotomi atau ruptur perineum akan mempengaruhi fungsi seksual. Beberapa perempuan merasa cemas atau takut jahitan robek dan berdarah, sehingga mengurangi kenikmatan berhubungan seksual. Sementara itu, pada masa menyusui, tubuh perempuan Kembali mengalami perubahan hormonal yang signifikan, termasuk penurunan estrogen dan progesteron. Hal inilah yang menjadi penyebab perubahan libido dan fungsi seksual (Eryilmaz and Erenel 2023).

2. Faktor Psikologis

Pasca persalinan selain perubahan fisik, kondisi psikologis juga berperan penting dalam kesehatan seksual perempuan. Faktor psikologis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seksual pasca persalinan, seperti: depresi, kecemasan, citra tubuh negatif, trauma persalinan, kurangnya dukungan emosional dan perubahan peran serta identitas. Depresi pasca persalinan adalah kondisi yang umum terjadi pada banyak wanita setelah melahirkan. Gejala depresi ini meliputi perasaan sedih yang mendalam, kelelahan, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas seksual. Tosun dan Bulut, (2021) mengungkapkan kecemasan, depresi dan gangguan psikologis pasca persalinan dapat mengurangi hasrat seksual dan menyebabkan kesulitan dalam menikmati hubungan. Kecemasan umumnya disebabkan karena ibu khawatir tidak mampu merawat bayi, kelelahan dan perubahan peran menjadi ibu. Kecemasan ini dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi minat pada aktivitas seksual.

Perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan dan persalinan sangat berpengaruh terhadap citra tubuh perempuan. Terjadinya peningkatan berat badan, perubahan bentuk tubuh, berkurangnya penampilan fisik, dapat menurunkan rasa percaya diri perempuan pasca bersalin. Perubahan fisik lainnya seperti timbulnya stretchmark dan hiperpigmentasi pada area perut, paha, payudara. Hal ini menyebabkan persepsi negatif terhadap citra tubuh sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri yang berdampak pada berkurangnya libido (Pardell-Dominguez et al. 2021).

Faktor psikologis lainnya yang dapat menyebabkan gangguan Kesehatan seksual adalah pengalaman persalinan yang traumatis, seperti persalinan dengan tindakan atau komplikasi medis. Pengalaman persalinan yang tidak menyenangkan akan menimbulkan traumatis pada perempuan dan dapat meninggalkan dampak psikologis. Pengalaman traumatis ini akan menyebabkan ketakutan atau kecemasan saat berhubungan seksual. Perempuan yang mengalami trauma dengan proses persalinannya, merasa lebih enggan untuk melakukan hubungan seksual (Geuens, Mivšek, and Gianotten 2023).

3. Hubungan psikososial

Hubungan psikososial pasca persalinan dapat berupa interaksi sosial dan dukungan emosional yang diterima perempuan selama dan setelah proses persalinan. Hal ini termasuk dukungan dari pasangan, keluarga, orang-orang terdekat, dan tenaga kesehatan pemberi asuhan. Terganggunya hubungan psikososial akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat membuat perempuan merasa lebih tenang dan percaya diri selama proses persalinan dan pemulihan pasca persalinan.

Dukungan ini bisa berupa kata-kata penyemangat, mendengarkan keluh kesah ibu, atau hanya hadir di sisinya. Hadirnya teman-teman atau tetangga untuk membantu merawat bayi atau menyediakan makanan dapat meringankan beban ibu, sehingga meningkatkan rasa percaya diri (Dinni and Ardiyanti 2020). Komunikasi yang baik antara ibu dengan orang-orang di sekitarnya sangat penting. Mendengarkan dan menghargai perasaan serta kebutuhan ibu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung (Dinni and Ardiyanti 2020).

Terganggunya hubungan psikososial pada perempuan pasca persalinan dapat berdampak besar pada kesehatan seksual. Hubungan psikososial juga berupa komunikasi yang terjalin antara perempuan dengan orang-orang disekitarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi yang dialami ibu pasca persalinan dapat mempengaruhi libido dan fungsi seksual. Perempuan yang mengalami kecemasan dan tekanan menjadi kurang tertarik pada aktivitas seksual atau mengalami kesulitan dalam mencapai kepuasan seksual. Perasaan tidak disayang dan dicintai juga dapat mempengaruhi kesehatan seksual ibu (Graziottin, Di Simone, and Guarano 2024).

E. Perawatan Kesehatan Seksual Pada Ibu Pasca Persalinan

Perempuan mengalami berbagai macam perubahan hormonal, fisik, dan emosional selama masa pasca persalinan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, hubungan, dan seksualitas. Disfungsi seksual pascapersalinan merupakan masalah klinis serius dan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan perempuan.

Kesehatan seksual merupakan bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan setiap individu dan memerlukan pendekatan biopsikososial. Kepuasan seksual merupakan komponen penting dari kehidupan seks yang sehat. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban profesional dan moral untuk meningkatkan kesehatan seksual klien dengan menyebarkan informasi yang akurat dan jika diperlukan, bimbingan tentang isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas. Tanggung jawab tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan seksual pada semua tingkatan. Pada tingkat mikro berperan dalam mempererat hubungan dengan klien/pasangan. Pada tingkat meso membantu klien dalam lingkup yang lebih luas, seperti di antara rekan kerja dan dalam lingkungan kemasyarakatan. Pada tingkat makro berupaya untuk mengurangi tabu seputar seksualitas di masyarakat, mendekonstruksi mitos-mitos seputar seksualitas dan mengadvokasi para pembuat kebijakan

1. Waktu yang tepat melakukan hubungan seksual pasca salin

Ibu yang mengalami komplikasi persalinan akibat robekan perineum, jahitan dan/atau persalinan dengan alat bantu disarankan untuk menghindari hubungan seks penetratif selama 4–6 minggu hingga luka sembuh. Beberapa hasil penelitian mendapatkan hasil: permasalahan kesehatan seksual banyak dirasakan oleh ibu pasca bersalin, khususnya pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Prevalensi bervariasi berkisar antara 18–61% dirasakan pada tiga bulan setelah melahirkan hingga 9–40% pada 12 bulan pasca persalinan. Permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh ibu berupa: dispareunia (nyeri saat penetrasi), lubrikasi vagina, libido yang menurun dan orgasme (O'Malley, Higgins, and Smith 2023).

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan kapan pasangan dapat kembali melakukan hubungan adalah membahas masalah kesehatan seksual pasca persalinan pada kelas ibu hamil. Topik ini sebaiknya dibahas pada antenatal tentang adaptasi menjadi orangtua setelah melahirkan, namun masih sangat jarang dilakukan. Selain itu, tidak semua ibu hamil menghadiri kelas antenatal, sehingga Sebagian besar keluarga tidak menerima informasi tentang kesehatan seksual setelah melahirkan. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi tentang waktu yang tepat melakukan hubungan seksual pasca salin saat melakukan kunjungan nifas dirumah.

2. Dispareunia

Dispareunia merupakan gangguan nyeri genital-pelvis atau nyeri seksual, dimana nyeri terjadi selama melakukan hubungan seksual, nyeri selama penetrasi dan jarang nyeri saat orgasme. Dispareunia dapat terjadi pada saat hubungan seksual selama pertama setelah melahirkan. Penyebab dispareunia adalah karena rusaknya saraf pudendal oleh tekanan kepala janin, atau cedera saraf akibat peregangan dorongan dalam waktu yang lama pada persalinan dengan kala II memanjang. Otot levator ani, yang diregangkan selama kelahiran, menyusut pasca-kelahiran. Perempuan terkadang merasakan sensasi seperti tekanan yang tidak dialami sebelum melahirkan. Dispareunia terkadang disertai dengan kekeringan vagina yang terjadi pasca persalinan, hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit dan ketidaknyamanan saat hubungan seksual (Horvath, Kloesel, and Cross 2024).

Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi untuk mengurangi dispareunia yang dirasakan ibu pasca salin. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah: a). menjelaskan kepada ibu penyebab terjadinya nyeri; b). menyarankan ibu untuk menyampaikan kepada suami, sehingga suami tidak melakukan penetrasi yang memperberat rasa nyeri; c). menggunakan lubricant untuk mengurangi nyeri; d). melakukan foreplay lambat agar ibu lebih siap; e).

menganjurkan ibu dan suami untuk mencari posisi yang ibu tidak merasakan nyeri (Geuens, Mivšek, and Gianotten 2023)

3. Kekurangan pelumasan vagina

Perubahan pada pelumasan vagina sering terjadi bulan setelah melahirkan. 57% ibu mengalami kekurangan pelumasan vagina 3 bulan pasca persalinan, berkurang menjadi 30% 12 bulan setelah melahirkan. Berkurangnya pelumasan vagina disebabkan oleh fluktuasi kadar estrogen pasca persalinan. Hormon estrogen dan progesteron menurun setelah kelahiran bayi dan plasenta. Setelah 6 minggu hingga 6 bulan, kadarnya kembali ke konsentrasi sebelum hamil. Kadar estrogen yang rendah memengaruhi lapisan epitel mukosa vagina sehingga terjadi penipisan mukosa dan berkurangnya kapasitas pelumasan. Meningkatnya kadar kortisol dapat terjadi bila ibu mengalami gangguan psikologis. Ketika kadar kortisol meningkat, maka akan menurunkan kadar testosteron. Hal ini mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual (Geuens, Mivšek, and Gianotten 2023).

Asuhan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kekurangan pelumasan vagina pasca-persalinan antara lain: a). menyampaikan kepada ibu agar mengomunikasikan dengan suami tentang masalah yang dirasakannya; b). menganjurkan ibu untuk menggunakan pelumas berbahan dasar air saat berhubungan seksual; c). anjurkan ibu menggunakan pelumas organik berkualitas baik berbahan dasar air; d). hindari pelumas dan mengandung gliserin yang dapat mengiritasi vagina dan meningkatkan ketidaknyamanan atau rasa sakit; e). gunakan kondom atau sex toys berbahan dasar silikon.

4. Hilangnya hasrat seksual pasca bersalin

Hilangnya hasrat seksual setelah bersalin disebabkan karena keinginan untuk tidur dan waktu untuk sendiri bisa lebih besar daripada keinginan untuk aktivitas seksual. Hal ini terjadi terutama bagi ibu yang bersalin pertama pada 12 bulan pertama setelah melahirkan. Hasil penelitian melaporkan prevalensi tinggi kurangnya minat pada seks atau tidak ada hasrat seksual pada ibu primi para terjadi 61% pada tiga bulan pasca persalinan hingga 40–51% setelah 12 bulan pasca salin (Donarska 2023). Perubahan hasrat seksual yang dialami setelah bersalin merupakan adaptasi normatif terhadap peran sebagai orang tua, terutama dalam beberapa bulan pertama. Ketika hasrat seksual berubah, dan ibu mengkomunikasikan dengan jujur dengan pasangan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Tenaga kesehatan harus menyarankan ibu agar mau berdiskusi masalah yang dirasakannya kepada suami.

Dispareunia, libido rendah, dan masalah seksual lainnya dapat merupakan masalah kesehatan seksual bagi wanita pasca persalinan. Perlukaan pada vagina atau perineum dalam tingkat apa pun dapat menimbulkan masalah kesehatan seksual. Selain itu, fungsi seksual secara keseluruhan dapat menurun selama kehamilan sehingga sulit untuk kembali ke tingkat fungsi seksual sebelum hamil. Trauma terhadap proses persalinan dapat menyebabkan berbagai efek psikologis seperti stres pascatrauma, depresi, atau kondisi kesehatan mental lainnya. Tenaga kesehatan seyogyanya melakukan pencegahan untuk mengurangi trauma kelahiran dapat meningkatkan kesehatan mental dan seksual ibu.

5. Latihan kegel

Latihan Kegel adalah latihan yang dirancang untuk menguatkan otot dasar panggul, yang mendukung organ-organ seperti kandung kemih, rahim, dan usus besar. Latihan ini ditemukan oleh Dr. Arnold Kegel pada tahun 1948 dan sangat bermanfaat untuk berbagai kondisi, terutama bagi wanita yang telah melahirkan. Manfaat senam kegel adalah untuk pemulihan pasca bersalin; membantu mempercepat pemulihan otot dasar panggul yang mungkin melemah atau rusak selama persalinan; mengurangi risiko inkontinensia urin; menguatkan otot-otot yang mengendalikan buang air kecil dan membantu mencegah inkontinensia urin.

Tenaga kesehatan dapat mengajarkan ibu untuk melakukan latihan kegel. Latihan kegel dapat meningkatkan kepuasan seksual dengan memperbaiki sirkulasi darah ke daerah panggul dan memperkuat otot-otot yang terlibat dalam aktivitas seksual. Manfaat lainnya untuk membantu mencegah prolaps organ panggul, yaitu kondisi di mana organ panggul turun dari posisi normalnya.

Senam kegel dapat dilakukan dengan mencoba menghentikan aliran urin saat buang air kecil. Otot yang digunakan untuk menghentikan aliran urin adalah otot dasar panggul. Ibu disarankan untuk mengambil posisi yang nyaman seperti berbaring atau duduk, selanjutnya minta ibu untuk mengencangkan otot dasar panggul dan menahan selama 3-5 detik, lalu rilekskan otot selama 3-5 detik. Minta ibu untuk mengulangi latihan ini 10-15 kali per sesi. Frekuensi latihan 3 kali sehari untuk hasil yang optimal. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan senam kegel adalah: jangan menahan nafas, pastikan untuk bernapas secara normal saat melakukan latihan. Hindari mengencangkan otot lain, fokus hanya pada otot dasar panggul dan hindari mengencangkan otot perut, paha, atau bokong. Minta ibu untuk konsistensi melakukan latihan. Latihan kegel yang rutin akan memberikan manfaat jangka panjang. Melakukan senam kegel secara rutin dapat memperkuat otot dasar panggul dan meningkatkan kualitas kesehatan seksual

F. Simpulan

Seksualitas bukan hanya sebagai sarana agar perempuan dapat hamil, namun harus terpenuhinya kesehatan seksual agar tercapai dan terpelihara, hak-hak seksual setiap orang. Kepuasan seksual merupakan komponen penting dari kehidupan seks yang sehat, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kesehatan seksual pada ibu pasca persalinan merupakan multi dimensi, dipengaruhi oleh fisik, psikologis dan psikososial. Tenaga kesehatan harus membantu ibu pasca bersalin untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat perubahan fisiologis yang terjadi selama hamil, bersalin, nifas dan menyusui.

G. Referensi

- Almuqahwi, Abdullah et al. 2023. "A Systematic Review on the Relationship Between Physical Activity and Sexual Function in Adults." *Cureus* 15(12).
- Boland, Mary Regina et al. 2020. "Female Reproductive Performance and Maternal Birth Month: A Comprehensive Meta-Analysis Exploring Multiple Seasonal Mechanisms." *Scientific Reports* 10(1): 1–13.
- Clark-Patterson, Gabrielle, Mari Domingo, and Kristin S Miller. 2022. "Biomechanics of Pregnancy and Vaginal Delivery Gabrielle." *Sciencedirect*. 1–21.
- Dinni, Siti Muthia, and Difa Ardiyanti. 2020. "Predictors of Postpartum Depression: The Role of Emotion Regulation, Maternal Self-Confidence, and Marital Satisfaction on Postpartum Depression." *Jurnal Psikologi* 47(3): 220.
- Donarska, Julia. 2023. *European Journal of Midwifery Factors Affecting for Women's Sexual Functioning after Childbirth-Pilot Study*.
- ERYILMAZ, Nergiz, and Ayten ŞENTÜRK ERENEL. 2023. "Sexuality and Counseling in Postpartum Women." *Journal of Gazi University Health Sciences Institute* 5(2): 59–67.
- Geuens, Sam, Ana Polona Mivšek, and Woet L. Gianotten. 2023. *Midwifery and Sexuality Midwifery and Sexuality*.
- Graziottin, Alessandra, Nicoletta Di Simone, and Alice Guarano. 2024. "Postpartum Care: Clinical Considerations for Improving Genital and Sexual Health." *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 296(November 2023): 250–57. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.02.037>.
- Horvath, Balazs, Benjamin Kloesel, and Sarah N. Cross. 2024. "Persistent Postpartum Pain – A Somatic and Psychologic Perfect Storm." *Journal of Pain Research* 17(December 2023): 35–44.
- Howard, A. Fuchsia et al. 2024. "Women's Self-Management of Dyspareunia Associated With Endometriosis: A Qualitative Study." *Journal of Pain* 25(8): 104492. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2024.02.006>.

- Maslow, Abraham H. 1954. Harper&Row Publisher INC *Motivation and Personality*. New York.
- O'Malley, Deirdre, Agnes Higgins, and Valerie Smith. 2023. "Sexuality of the Couple in Postpartum and Early Parenthood (1st Year)." *Midwifery and Sexuality*. 85–98.
- Pardell-Dominguez, Lidia et al. 2021. "The Meaning of Postpartum Sexual Health for Women Living in Spain: A Phenomenological Inquiry." *BMC Pregnancy and Childbirth* 21(1): 1–13.
- Pratama, Bambang Hady. 2020. "Perbandingan Fungsi Seksual Berdasarkan Female Sexual Function Index Antara Primipara Pasca Persalinan Normal Dengan Pasca Seksio Sesaria." : 1–38. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/630/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/630/2/C105215202_tesis_23-10-2020_1-2.pdf.
- Sabola, Nabila E. et al. 2020. "Sexual Nursing Care for the Postpartum Period and Its Impact on Sexual Dysfunction and Life Satisfaction Among Egyptian Women." *Malaysian Journal of Public Health Medicine* 20(2): 108–15.
- Tosun, Şebnem Alanya, and Muhammet Bulut. 2021. "Evaluation of Factors Affecting Depression and Sexual Dysfunction in the Postpartum Period." *Van Medical Journal* 28(2): 204–10.
- Vaamonde, Diana, Stefan S. du Plessis, and Ashok Agarwal. 2016. "Exercise and Human Reproduction: Induced Fertility Disorders and Possible Therapies." *Exercise and Human Reproduction: Induced Fertility Disorders and Possible Therapies* (March): 1–351.
- WHO. 2017. "Sexual Health and Its Linkages to Reproductive Health: An Operational Approach." *World Health Organization*. 1–12. <https://bmccancer.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12885-019-6009-2.pdf>.
- Wood, Shannon N. et al. 2022. "A Scoping Review on Women's Sexual Health in the Postpartum Period: Opportunities for Research and Practice within Low-and Middle-Income Countries." *Reproductive Health* 19(1): 1–34. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01399-6>.

CHAPTER 4

TREN KONTRASEPSI MODERN: PILIHAN DAN TANTANGANNYA

Tinuk Esti Handayani, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, menempati urutan keempat setelah China, India dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 281,603,1 juta jiwa. Diantara ASEAN, Indonesia menempati urutan kelima tertinggi dari sebelas negara untuk Angka Kelahiran Total dengan 2,45 (BPS, 2020). Dampak peledakan penduduk yaitu meningkatnya kemiskinan dan kelaparan, kurang gizi pada balita, kematian ibu dan anak, pengangguran meningkat (Priyatni & Sri Rahayu, 2016). Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Negara ataupun seluruh Negara dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (Netral, 2021).

Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan salah satunya dengan penjarangan kelahiran. KB individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran (Priyatni & Sri Rahayu, 2016). Dengan adanya program keluarga berencana diharapkan meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Dengan pemakaian kontrasepsi di masyarakat. sangat penting untuk mencegah stunting."Peran ini sangat sentral, karena semakin dekat jarak anak, semakin stunting. Jadi kehamilan ke kehamilan berikutnya menentukan tinggi rendahnya stunting," Menurut data World Health Organization (WHO), penggunaan kontrasepsi modern di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan. Penggunaan kontrasepsi hormonal mendominasi dengan 75% dari pengguna global, sementara 25% menggunakan metode non-hormonal (Sulastri, 2023, dari 37.338.265 Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia, terdapat 23.606.218 peserta KB aktif. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi implan dengan 1.650.227 pengguna (6,99%), IUD dengan 1.688.685 pengguna, MOP dengan

124.262 pengguna (0,53%), dan MOW dengan 655.762 pengguna (2,78%). Sementara itu, untuk metode kontrasepsi non-MKJP, terdapat 14.817.663 pengguna (62,77%), dengan rincian 4.069.844 pengguna pil (17,24%) dan 288.388 pengguna kondom (1,22%) (Astuti, 2021). Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Indonesia baru mencapai 10,2% sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek. Dalam laporan Profil Kesehatan Indonesia (Profil Kesehatan Indonesia) tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas akseptor kontrasepsi memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil daripada memilih kontrasepsi jangka panjang.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wahidin menyatakan bahwa prevalensi penggunaan kontrasepsi modern atau modern contraceptive prevalence rate (mCPR) di Indonesia masih belum sesuai target. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam penggunaan alat kontrasepsi modern."Tantangan terkini terkait kontrasepsi semakin tinggi pendidikannya memang sepertinya mereka lebih percaya diri menggunakan kontrasepsi alami. Ia mengatakan masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung mengatur secara mandiri ritme masa subur dan menstruasinya. Rendahnya pendidikan juga terkait erat dengan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi. Pemahaman yang kurang baik tentang KB menjadi hambatan dalam membentuk sikap yang positif program KB. Banyak perempuan masih memegang teguh mitos dan miskonsepsi terhadap kontrasepsi modern. Keputusan menggunakan kontrasepsi atau tidak pada wanita dengan tingkat pendidikan rendah sangat dipengaruhi oleh keputusan suami. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi BKKBN untuk terus meningkatkan edukasi pemakaian kontrasepsi modern, seperti pil, kondom, implant (susuk), dan lainnya. Meskipun pemerintah gencar mensosialisasikan manfaat kontrasepsi, fakta menunjukkan bahwa tingkat penggunaan kontrasepsi modern semakin melorot. Salah satu faktor yang berperan dalam penurunan ini adalah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, yang sering kali menyesatkan dan menghambat adopsi metode kontrasepsi yang lebih efektif.

B. Tantangan Dalam Penggunaan Kontrasepsi Modern

Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang merupakan indikator utama kesehatan reproduksi, dengan mengendalikan penduduk melalui kontrasepsi. Pemerintah Indonesia pertama kali meluncurkan program keluarga berencana pada tahun 1969 untuk menyediakan layanan kontrasepsi, mengurangi kelahiran, dan mempromosikan kesetaraan gender. Keberhasilan program KB salah satunya dapat diukur dari peningkatan

jumlah pengguna alat kontrasepsi dari tahun ke tahun. Penggunaan alat kontrasepsi diharapkan juga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut DP3AP2KB (2004) Berikut beberapa alasan mengapa mitos menjadi hambatan utama dalam penggunaan kontrasepsi modern.

1. Mitos tentang Dampak Kesehatan

Salah satu mitos terbesar yang beredar di masyarakat adalah anggapan bahwa kontrasepsi modern, seperti pil KB, suntik KB, dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang serius. Banyak orang percaya bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan kegemukan, gangguan menstruasi, hingga risiko kanker. Meskipun beberapa efek samping mungkin terjadi, risikonya sangat kecil dan tidak sebesar yang dibayangkan. Padahal, penelitian medis telah membuktikan bahwa sebagian besar metode kontrasepsi modern aman digunakan dan tidak menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan. Namun, ketidakpahaman masyarakat terhadap informasi medis yang benar, ditambah dengan penyebaran mitos, membuat banyak pasangan muda maupun pasangan yang sudah berkeluarga merasa ragu untuk menggunakan metode kontrasepsi modern.

2. Mitos Tentang Fertilitas yang Menurun

Mitos lain yang sangat berpengaruh adalah anggapan bahwa penggunaan kontrasepsi modern dapat menurunkan kesuburan atau membuat seseorang sulit untuk hamil setelah berhenti menggunakan kontrasepsi. Kepercayaan ini sering kali membuat wanita takut untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, seperti suntik KB atau implan, karena khawatir akan mengalami masalah kesuburan di masa depan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar metode kontrasepsi, termasuk pil KB dan suntik KB, tidak menyebabkan gangguan permanen pada kesuburan. Kesuburan wanita akan kembali normal begitu penggunaan kontrasepsi dihentikan. Mitos ini, meskipun sudah dibantah oleh tenaga medis, tetap memengaruhi banyak pasangan untuk enggan menggunakan kontrasepsi modern.

3. Mitos Tentang Pengaruh pada Kehidupan Seksual

Beberapa mitos yang beredar menyebutkan bahwa penggunaan kontrasepsi dapat mengurangi kenikmatan seksual atau menurunkan libido. Ada yang percaya bahwa pil KB atau alat kontrasepsi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi dapat mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan intim. Padahal, kenyataannya kontrasepsi modern dapat meningkatkan kenyamanan seksual dengan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan,

mengurangi stres terkait kekhawatiran akan kehamilan, dan memungkinkan pasangan untuk lebih fokus pada kualitas hubungan seksual mereka. Mitos ini tentu saja memperburuk pandangan tentang kontrasepsi modern, padahal fungsinya adalah untuk memberi kebebasan bagi pasangan untuk merencanakan kehamilan tanpa mengorbankan kepuasan seksual.

4. Mitos Tentang Kontrasepsi yang Tidak Sesuai dengan Agama atau Budaya

Dalam beberapa komunitas, terutama di daerah-daerah dengan pengaruh budaya dan agama yang kuat, berkembang mitos bahwa kontrasepsi modern bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai budaya. Beberapa orang percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi adalah suatu bentuk "perencanaan keluarga" yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa kontrasepsi modern dapat merusak moralitas atau merendahkan nilai-nilai kehidupan keluarga. Padahal, pandangan agama dan budaya terhadap kontrasepsi bervariasi. Banyak ajaran agama yang tidak melarang penggunaan kontrasepsi modern selama itu dilakukan dengan alasan yang sah, seperti untuk kesehatan atau kesejahteraan keluarga. Sayangnya, penyebaran mitos ini membuat banyak orang merasa terjebak dalam norma yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Wanita usia subur enggan menggunakan kontrasepsi modern karena lebih tertarik menggunakan metode kontrasepsi tradisional seperti jamu, pijat, dan metode kalender. Selain itu, penggunaan kontrasepsi juga dipengaruhi oleh akses layanan penyedia kontrasepsi dan biaya.

5. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Mitos

Di era digital ini, penyebaran informasi tidak hanya terbatas pada media tradisional. Media sosial menjadi saluran yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Mitos-mitos tentang kontrasepsi sering kali viral di platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram, sehingga lebih banyak orang terpapar dengan informasi yang keliru. Seringkali, informasi ini didasarkan pada pengalaman pribadi yang tidak relevan atau bahkan hoaks, yang semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang kontrasepsi.

6. Pengangguran pada wanita multipara

Wanita yang bekerja cenderung memilih untuk membatasi jumlah anak. Perempuan yang bekerja dapat memutuskan sendiri apakah akan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Faktor lain yang ditemukan sebagai penghambat penggunaan kontrasepsi pada Wanita multipara di Indonesia adalah kesulitan dalam mengakses layanan dan kemampuan ekonomi. (Ratna 2021). Untuk mengatasi penurunan penggunaan kontrasepsi modern akibat mitos-mitos ini,

dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam hal edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern di antaranya: Melaksanakan layanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak, seperti yang dilakukan pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan peserta KB, khususnya KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

1. Melaksanakan program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR yang gratis. Program ini menyediakan layanan KB non hormonal, IUD, dan implan.
2. Selain itu, penting untuk mengatasi stigma dan ketakutan yang tidak berdasar terhadap kontrasepsi melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada kebutuhan serta kekhawatiran pasangan. Dengan pendekatan yang tepat, mitos-mitos ini bisa dilawan dan penggunaan kontrasepsi modern dapat meningkat, demi tercapainya kesejahteraan keluarga dan kesehatan reproduksi yang lebih baik.
3. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaring, termasuk tenaga kesehatan yang melayani KB. Dengan menjelaskan metode kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan, membantu calon akseptor KB memilih kontrasepsi yang tepat, dan membuat calon akseptor KB merasa nyaman saat pelayanan KB. Selain itu, juga menginformasikan kemungkinan efek samping pemakaian metode kontrasepsi, meminta akseptor KB kembali untuk kunjungan ulang pelayanan KB, melakukan konseling KB pada saat antenatal care pemantauan kualitas pelayanan KB secara mandiri, serta penanganan efek samping KB .

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia

1. Sosial Ekonomi

Tinggi rendahnya status social dan keadaan ekonomi penduduk di Indonesia akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa terlepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang di gunakan dengan suksesnya program KB maka perekonomian suatu negara akan lebih baik krena dengan anggota keluarga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan sejahtera dapat terjamin

2. Sosial Budaya

Sejumlah factor budaya dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi. Faktor-faktor ini meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religious, serta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko kehamilan dan status wanita

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi kerelaan menggunakan KB tetapi juga pemilihan suatu metode. Wanita yang berpendidikan menginginkan keluarga berencana yang efektif, tetapi tidak rela untuk mengambil resiko yang terkait sebagai metode kontrasepsi

4. Agama

Berbagai daerah kepercayaan religious dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode. Berbagai contoh penganut katolik yang taat membatasi kontrasepsi mereka yang memakai KB alami. Agama Islam tidak melarang metode kontrasepsi secara umum, akseptor wanita berpendapat pola pendarahan yang tidak teratur disebabkan metode hormonal akan sangat menyulitkan mereka selama haid. Masyarakat hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid sehingga pola haid yang tidak teratur dapat menjadi masalah

5. Status Wanita

Wanita dalam masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi. Di daerah yang status wanitanya meningkat, memiliki pemasukan yang lebih besar untuk memilih metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam mengambil keputusan.

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang telah lama diterapkan di Indonesia untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan program KB.

1. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB dalam menjaga kesejahteraan keluarga.
2. Keluarga Berencana bukan hanya tentang mengendalikan jumlah anak, tetapi juga tentang kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan." Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal ini dan menganggap KB hanya sebagai alat kontrol jumlah anak.
3. Masalah aksesibilitas juga menjadi tantangan dalam penerapan KB di Indonesia. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan untuk memberikan layanan KB. Hal ini membuat banyak pasangan di daerah tersebut sulit mendapatkan informasi dan layanan KB yang mereka butuhkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat dan terukur. Salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya KB melalui berbagai media, seperti kampanye di media sosial atau acara talkshow di televisi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka akan lebih memahami manfaat dari KB dan mau untuk menerapkannya dalam keluarga mereka.

Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan aksesibilitas layanan KB di daerah-daerah terpencil. Menurut Prof. Budi, seorang pakar demografi, "Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pasangan di seluruh Indonesia dapat dengan mudah mengakses layanan KB yang mereka butuhkan." Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah pusat layanan KB dan mendukung tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah-daerah terpencil.

Dengan upaya yang terus-menerus dan kolaborasi antara pemerintah, ahli kesehatan, dan masyarakat, diharapkan tantangan dalam penerapan KB di Indonesia dapat teratasi. Sehingga, keluarga di Indonesia dapat hidup dengan lebih sehat, sejahtera, dan berencana. (BKKBN 2015)

C. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternative untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan atau perencanaan keluarga. KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran (Hartanto, 2010). Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (fertilisasi), atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang didalam rahim. Kontrasepsi dapat bersifat reversibel (kembali) atau permanen (tetap). Kontrasepsi yang reversibel adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk kembali memiliki anak. KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran

Faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektifitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Selain hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya serta peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut, faktor lainnya adalah frekuensi melakukan hubungan seksual

1. Tujuan keluarga berencana

- a. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan Sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.
- b. terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Manfaat Keluarga Berencana

- a. Terhadap Pengendalian penduduk (Bangsa dan Negara)
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional
- b. Manfaat Keluarga Berencana bagi kepentingan nasional
Meningkatkan derajat kesehatan dan Kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya. Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksi.
- c. Manfaat Program Keluarga Berencana Terhadap Pencegahan Kelahiran
Mengatur jumlah dan jarak Kelahiran sehingga perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dan terlalu dekat. Serta Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan lainnya.
- d. Manfaat untuk anak-anak yang di lahirkan
 - 1) Anak dapat tumbuh secara wajar dan sehat karena ibu yang mengandungnya dalam keadaan sehat.
 - 2) Sesudah lahir, anak mendapat perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan direncanakan
 - 3) Memberi kesempatan kepada anak agar perkembangan fisiknya lebih baik, karena setiap anak memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga.
 - 4) Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena pemeliharaan lebih baik dan lebih banyak waktu yang dapat diberikan oleh ibu untuk setiap anak .

- 5) Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik karena sumber-sumber pendapatan keluarga tidak habis untuk mempertahankan hidupsemata-mata.
- e. Manfaat untuk ayah
Memberikan kesempatan kepadanya agar dapat: Memperbaiki kesehatan fisiknya dan memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu terluang untuk keluarganya
- f. Manfaat untuk seluruh keluarga
Kesehatan mental, fisik, sosial setiap anggota keluarga tergantung dari kesehatan seluruh keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan.

D. Metode Kontrasepsi Modern

Kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang menggunakan alat, obat, atau bahan kimia untuk mencegah kehamilan. Metode ini umumnya memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Sedangkan Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan kehamilan setelah hubungan seksual dengan menghambat sperma mencapai ovum matang atau dengan mencegah ovum yang dibuahi tertanam pada endometrium. (Hanafi 2010) Penggunaan metode kontrasepsi modern memajukan hak asasi manusia untuk secara bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka. (Afandi 2021)

1. Metode dan jenis kontrasepsi Modern

- a. Kontrasepsi Oral Kombinasi Pil yang mengandung 2 macam hormon berdosisi rendah yaitu progestin dan estrogen-seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium. Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK) yang disediakan Pemerintah: Pil Monofasik yang mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam dosis yang sama yaitu 21 pil mengandung 30 µg Ethynil Estradiol (EE)/150 µg Levonorgestrel (LNG) dan 7 pil tanpa hormon. Kelebihan dari pil KB yaitu dapat mengurangi pendarahan pada saat haid, sedangkan kekurangannya yaitu dapat menambah berat badan dan meningkatkan risiko hipertensi tanpa hormon.
- b. PIL Progestin
Pil dengan dosis progestin yang sangat rendah. Karena tidak mengandung estrogen, pil ini dapat digunakan selama menyusui dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode yang mengandung estrogen. Pil ini bekerja terutama dengan mengentalkan lendir serviks (untuk menghalangi sperma bertemu sel telur) dan mengganggu siklus menstruasi. Kelebihan dari pil KB

yaitu dapat mengurangi pendarahan pada saat hai, sedangkan kekurangannya yaitu dapat menambah berat badan dan meningkatkan risiko hipertensi. Efektifitas 98,5 % jika Tidak ada tablet yang lupa ,di gunaka pada jam yang sama.

c. Kontrasepsi Suntik Kombinasi

Suntikan bulanan mengandung progestin dan estrogen. Disebut juga kontrasepsi suntik kombinasi, , yang diberikan injeksi IM sebulan sekali (cyclovem) dan 50 mg noretindron enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. suntikan. Berfungsi terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium

d. Kontrasepsi Suntikan Progestin/ DMPA

Kontrasepsi progestin suntik meliputi depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) dan noretisteron enantat (NET-EN). Karena tidak mengandung estrogen, kontrasepsi ini dapat digunakan selama menyusui dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode yang mengandung estrogen. Kontrasepsi ini biasanya disuntikkan ke otot (injeksi intramuskular). Formulasi DMPA yang lebih baru dapat disuntikkan tepat di bawah kulit (injeksi subkutan) dapat menghentikan terjadinya ovulasi Kelebihan dari alat kontrasepsi yang satu ini yaitu lebih efektif apabila dibandingkan pil KB dan tingkat kegagalannya kurang dari 1%. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu harganya yang relatif lebih mahal dan tidak memiliki perlindungan terhadap penyakit menular seksual, serta menyebabkan siklus haid berantakan

e. Implan

Implan adalah batang plastik kecil yang melepaskan progestin. Penyedia layanan kesehatan terlatih melakukan prosedur pembedahan kecil untuk menempatkan 1 atau 2 batang di bawah kulit di bagian dalam lengan atas wanita. Implan tidak mengandung estrogen, sehingga dapat digunakan selama menyusui dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode yang mengandung estrogen. Jenis implan meliputi Jadelle, Implanon NXT (juga dikenal sebagai Nexplanon), dan Levoplant. Kelebihan dari implan ini adalah tingkat kegagalannya yang relatif lebih rendah dan cukup tahan lama. Akan tetapi, biaya implan ini lebih mahal dan tidak dapat memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual.

f. Patch Contraceptive (Koyo KB)

Patch atau koyo KB mengandung hormon estrogen dan progestin. Seperti layaknya penggunaan koyo, alat KB ini ditempelkan pada tubuh wanita untuk mencegah ovulasi. Koyo ditempelkan selama 1 minggu, kemudian diganti dengan koyo yang baru selama 3 minggu berturut-turut. Pada minggu ke-4,

Anda tidak perlu menempelkan koyo karena diharapkan Anda akan mengalami menstruasi. Keuntungan dari jenis KB ini adalah mudah dan tidak memerlukan tindakan, sedangkan kekurangannya adalah Anda harus mengingat untuk menggantinya setiap minggu, tidak mencegah Anda dari infeksi menular seksual, dan ada kemungkinan risiko iritasi atau alergi pada kulit yang ditempel.

g. IUD/ AKDR Hormonal

IUD levonorgestrel (LNG) adalah alat plastik berbentuk T yang melepaskan sejumlah kecil levonorgestrel secara bertahap setiap hari. Penyedia layanan kesehatan terlatih memasukkannya ke dalam rahim wanita melalui vagina dan serviks. Dipasarkan dengan merek dagang seperti Mirena, Liletta, Levosert, Kyleena, Skyla, dan Jaydess. Berfungsi dengan mencegah sperma membuahi sel telur.

h. IUD/AKDR

IUD (Intrauterine device) merupakan sebuah alat yang terbuat dari bahan plastik dan memiliki bentuk layaknya huruf T. Disebut juga sebagai KB spiral, alat ini dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan alat ini ke dalam rahim dengan bantuan dokter atau bidan. Meskipun begitu, kekurangan dari IUD ini adalah biayanya yang relatif lebih mahal, terdapat benang yang keluar melalui serviks, serta risiko efek samping yang dapat menyebabkan haid tidak lancar

i. MOW/Metode operatif Wanita

Kontrasepsi bedah permanen untuk wanita yang tidak ingin punya anak lagi. Dua pendekatan bedah yang paling sering digunakan adalah laparotomi mini dan laparoskopi. Disebut juga sterilisasi tuba, ligasi tuba, kontrasepsi bedah sukarela, tubektomi, ligasi bi-tubal, pengikatan tuba, minilap, dan "operasi". Berfungsi dengan cara menyumbat atau memotong tuba falopi. dapat dilakukan apabila sudah memastikan dan meyakinkan untuk tidak memiliki anak lagi. Metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas hampir 100% dalam mencegah kehamilan.

j. MOP/ Metode operatif pria

Kontrasepsi permanen bagi pria yang tidak ingin punya anak lagi. Disebut juga sterilisasi pria dan kontrasepsi bedah pria. Berfungsi dengan menutup setiap vas deferens, sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam air mani. Metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas hampir 100% dalam mencegah kehamilan.

E. Simpulan

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun). indikator yang penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana salah satu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Kontrasepsi modern. Keberhasilan program KB salah satunya dapat diukur dari peningkatan jumlah pengguna alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi diharapkan juga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam meningkatkan kepesertaan KB banyak di hadapkan tantangan yang dihadapi a antara lain adanya mitos, dan pengaruh budaya serta kesadaran masyarakat yang kurang. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektifitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Selain hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya serta peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut. Sehingga perlunya. Salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya KB melalui berbagai media, seperti kampanye di media sosial atau acara talkshow di televisi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka akan lebih memahami manfaat dari KB dan mau untuk menerapkannya dalam keluarga mereka. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas layanan KB di daerah-daerah terpencil. Dengan upaya yang terus-menerus dan kolaborasi antara pemerintah, ahli kesehatan, dan masyarakat, diharapkan tantangan dalam penerapan KB di Indonesia dapat teratasi. Sehingga, keluarga di Indonesia dapat hidup dengan lebih sehat, sejahtera, dan berencana.

F. Referensi

- Affandi B. 2021. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,
- BKKBN. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BKKBN. [https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP BKKBN - TAHUN 2020.pdf](https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP%20BKKBN%20TAHUN%202020.pdf)
- BPS, (2024) Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- DP3AP2KB (2024) Artikel Ilmiah gara -gara Mitos, Mengapa Penggunaan Kontrasepsi Menurun <https://opendata.cimahikota.go.id/artikel/gara-gara->

mitos-mengapa-penggunaan-kontrasepsi-modern-menurun

- Hartanto H 2010. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi , Jakarta: Pustaka sinar Harapan Pustaka.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Direktorat Jenderal Bina kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI .
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Direktorat Jenderal
- Netral, A. (2021). Melihat TFR Indonesia dalam Konteks Global. Artikel Ilmiah Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1380>
- Prijatni, I., & Sri Rahayu. (2016). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In Edisi 1. Kemenkes RI. http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/w_p-content/uploads/2017/08/Kespro-dan-KBKomprehensif.pdf
- Ratna Dwi Wulandari, Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Airlangga <https://unair.ac.id/hambatan-penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-multipara-di-indonesia>
- Yanty, R. D. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 121–124.

G. Glosarium

AKDR	= Alat Kontrasepsi dalam Rahim
IUD	= Intrauterine Device
KB	= Keluarga Berencana
MOP	= Metode Operatif Pria
MOW	= Metode Operatif Wanita
TFR	= Total Fertility Rate
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 5

PENCEGAHAN KANKER SERVIKS MELALUI EDUKASI DAN VAKSINASI

Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi perempuan dalam kelompok usia 15–49 tahun merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait ancaman kanker yang seringkali menimbulkan ketakutan. Setiap tahunnya, pada tanggal 4 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Sedunia dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan pencegahan terhadap penyakit kanker. Salah satu jenis kanker yang menempati peringkat kedua dengan 36.633 kasus (9,2% dari total kasus kanker) adalah kanker serviks, yaitu kanker yang menyerang leher rahim (Cut Mutiyya Bunsal, 2021). Kanker serviks, yang disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus (HPV), merupakan tumor ganas yang berkembang di area serviks. Sebagian besar kasus kanker ini terkait erat dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat dicegah, dan hampir semua kejadian kanker serviks dipicu oleh infeksi HPV (Faisal et al., 2022)

Upaya pencegahan yang efektif terhadap kanker serviks melibatkan pemberian vaksin HPV, yang dapat diberikan sejak usia 9 tahun untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyebaran infeksi HPV. Selain itu, perempuan berusia 13 hingga 26 tahun yang belum divaksinasi atau belum menyelesaikan seri vaksinasinya juga dianjurkan untuk menerima vaksin ini. Idealnya, vaksinasi dilakukan sebelum perempuan memasuki usia aktif secara seksual, yaitu periode ketika mereka paling rentan terhadap infeksi HPV. Mengingat tingginya prevalensi kanker serviks di negara-negara berkembang, vaksinasi HPV memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan perempuan di wilayah tersebut. (Faisal et al., 2022)

Hasil uji klinis menunjukkan bahwa vaksin HPV efektif dalam melindungi individu dari kutil kelamin, lesi prakanker pada vagina dan vulva, kanker serviks, serta infeksi HPV yang persisten. Perlindungan yang diberikan oleh vaksin ini terhadap beberapa strain HPV dapat bertahan selama 6–8 tahun, meskipun durasi perlindungan jangka panjangnya masih belum dapat dipastikan. Penting untuk dicatat bahwa vaksin ini tidak memberikan perlindungan jika seseorang sudah terinfeksi HPV. Oleh karena itu, skrining rutin untuk kanker serviks tetap diperlukan, dan vaksinasi tidak dapat menggantikan proses tersebut. Perempuan yang telah

divaksinasi tetap harus mengikuti rekomendasi medis, termasuk melakukan tes pap smear atau IVA secara berkala. (Faisal et al., 2022)

Masalah kesehatan seperti ini memerlukan pengelolaan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan melibatkan semua sektor terkait. Program pendidikan kesehatan, atau yang dikenal sebagai promosi kesehatan, bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Lebih dari sekadar menyebarkan informasi tentang pentingnya gaya hidup sehat, promosi kesehatan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang cara mencapainya. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas dengan menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. (Bahri et al., 2024)

Pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk cara mencegah kanker serviks, merupakan komponen kritis yang harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satu strategi promosi kesehatan yang efektif adalah mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam layanan kesehatan ibu dan anak, misalnya melalui distribusi materi edukasi yang dapat dibawa pulang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan vaksin HPV. Kampanye edukasi dan vaksinasi ini dirancang untuk memaksimalkan peran perempuan dalam meningkatkan kesadaran tentang HPV dan mendorong partisipasi dalam vaksinasi. (Bahri et al., 2024)

B. Kanker serviks

Kanker serviks, suatu kondisi ganas yang berasal dari pertumbuhan abnormal sel-sel di daerah serviks, merupakan masalah kesehatan yang serius, terutama bagi wanita berusia 30 hingga 40 tahun. Jenis kanker ini muncul di serviks—bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina—dan merupakan salah satu keganasan paling umum yang memengaruhi wanita secara global. Di Indonesia, kanker serviks menempati urutan kedua sebagai kanker spesifik wanita yang paling banyak terjadi, hanya dikalahkan oleh kanker payudara dalam hal angka kematian. Sangat memprihatinkan, diperkirakan satu wanita kehilangan nyawa akibat kanker serviks setiap jam, dengan 40 hingga 50 kasus baru didiagnosis setiap harinya. Dalam satu tahun saja, sekitar 15.000 kasus dilaporkan, yang mengakibatkan 8.000 kematian, menegaskan betapa seriusnya penyakit ini. (Suryoadji & Ridwan, Alifaturrasyid Syafaatullah, 2022)

Secara global, kanker serviks menyumbang sekitar 500.000 kasus baru setiap tahun, dengan 80% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang. Ketimpangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur

kesehatan dan akses ke tindakan pencegahan di wilayah-wilayah tersebut. Penyakit ini sering kali berkembang secara diam-diam, dengan banyak wanita tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga membuat deteksi dini dan intervensi menjadi sulit. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel epitel skuamosa di serviks mengalami perubahan abnormal dan mulai berkembang biak secara tidak terkendali, berpotensi membentuk tumor. Meskipun beberapa tumor tetap jinak, yang lain menjadi ganas, mengarah pada kanker serviks. (Suryoadji & Ridwan, Alifaturrasyid Syafaatullah, 2022)

Agen penyebab utama kanker serviks adalah strain human papillomavirus (HPV) berisiko tinggi, khususnya tipe 16 dan 18. Virus-virus ini bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kanker serviks di seluruh dunia. Selain itu, melakukan aktivitas seksual di usia muda, terutama sebelum usia 18 tahun, merupakan faktor risiko yang signifikan. Hal ini disebabkan sel-sel mukosa di area vagina pada individu yang lebih muda lebih rentan terhadap trauma dan perubahan seluler, menciptakan lingkungan yang mendukung masuk dan berkembangnya virus penyebab kanker. Aktivitas seksual dini dapat menyebabkan mikrorobekan dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi HPV, yang selanjutnya meningkatkan risiko berkembangnya kanker serviks di kemudian hari. Mengingat sifat asimtomatik dari kanker serviks stadium awal, skrining rutin sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan yang efektif. Wanita disarankan untuk menjalani pemeriksaan rutin hingga usia 70 tahun untuk mengidentifikasi perubahan pra-kanker atau kanker pada sel-sel serviks. Langkah-langkah pencegahan seperti ini sangat penting, karena kanker serviks dapat menyerang wanita yang pernah aktif secara seksual. Inisiatif kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran, mempromosikan vaksinasi HPV, dan memastikan akses ke skrining rutin merupakan langkah penting dalam mengurangi beban penyakit ini, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas di mana prevalensi dan angka kematian tetap tinggi. (Bahri et al., 2024)

C. Etiologi Kanker Serviks

Kanker serviks terutama disebabkan oleh infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV), yang memainkan peran sentral dalam patogenesis penyakit ini. Perkembangan karsinoma serviks erat kaitannya dengan proses biologis metaplasia, khususnya di area persimpangan skuamokolumnar, yang juga dikenal sebagai zona transformasi, di mana perubahan seluler umumnya terjadi. HPV ditularkan terutama melalui kontak kulit-ke-kulit dengan area yang terinfeksi, serta melalui hubungan seksual.

Studi epidemiologis telah membuktikan korelasi kuat antara insiden kanker serviks dan jenis HPV berisiko tinggi, dengan bukti yang signifikan menunjukkan bahwa infeksi HPV merupakan faktor penyebab dalam perkembangan neoplasia

serviks. Proses karsinogenesis pada kanker serviks dimulai setelah infeksi HPV, yang mengganggu mekanisme seluler normal di epitel serviks. Berbagai studi kasus-kontrol dan kohort telah menunjukkan Risiko Relatif (RR) antara 20 hingga 70 untuk hubungan antara infeksi HPV dan kanker serviks, menegaskan peran signifikan virus dalam perkembangan penyakit.

HPV terdiri dari lebih dari 150 jenis, di mana 13 di antaranya diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi karena potensinya untuk menyebabkan perubahan kanker. Di antara jenis-jenis ini, HPV tipe 16 dan 18 sangat terkenal karena hubungan kuatnya dengan kanker serviks. Penularan strain HPV berisiko tinggi ini terjadi terutama melalui kontak seksual, dengan sebagian besar individu terinfeksi tak lama setelah mulai aktif secara seksual. Namun, perkembangan dari infeksi awal hingga kanker serviks dapat memakan waktu beberapa tahun, menekankan sifat laten dari penyakit ini. (Shelemo, 2023)

Jenis HPV dapat dikategorikan secara luas menjadi dua kelompok berdasarkan potensi onkogeniknya:

1. Jenis HPV berisiko rendah: Kelompok ini mencakup HPV tipe 6 dan 11, yang jarang dikaitkan dengan transformasi ganas dan lebih sering dikaitkan dengan kondisi jinak seperti kutil kelamin.
2. Jenis HPV berisiko tinggi: Kelompok ini mencakup HPV tipe 16, 18, 31, 33, dan 45, yang semuanya sangat terkait dengan peningkatan risiko berkembangnya kanker serviks. (Shelemo, 2023)

D. Faktor Risiko

1. Faktor Risiko yang telah dibuktikan

a. Aktivitas Seksual

Mayoritas ahli medis sepakat bahwa kanker serviks termasuk dalam kategori penyakit menular seksual (PMS). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa riwayat seksual seseorang dapat berkorelasi dengan risiko terkena penyakit ini. Wanita yang memulai aktivitas seksual pada usia dini atau memiliki banyak pasangan seksual memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan kanker serviks. Hal ini disebabkan oleh mekanisme infeksi yang menjadi penyebab utama penyakit tersebut. Aktivitas seksual sebelum usia 18 tahun meningkatkan risiko kanker serviks hingga lima kali lipat karena sel-sel kolumnar serviks lebih rentan mengalami metaplasia selama masa perkembangan. Dengan demikian, aktivitas seksual dini dan multipartner merupakan faktor risiko signifikan bagi kanker serviks.

b. Karakteristik Partner

Meskipun sunat sebelumnya dianggap sebagai faktor protektif, penelitian terkini menunjukkan bahwa hal ini hanya sedikit mengurangi risiko. Studi kasus-kontrol mengungkapkan bahwa wanita dengan kanker serviks cenderung memiliki pasangan yang memiliki riwayat hubungan seksual berulang dengan banyak individu. Risiko ini semakin meningkat jika pasangan tersebut menderita kanker penis atau jika istri sebelumnya meninggal karena kanker serviks.

c. Riwayat Ginekologis

Usia menopause tidak secara langsung memengaruhi risiko kanker serviks. Namun, faktor-faktor seperti kehamilan multipel, kehamilan di usia remaja, dan perawatan persalinan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko tersebut.

d. Dietilstilbesterol (DES)

Paparan *diethylstilbestrol* (DES) selama kehamilan juga telah terbukti berkaitan dengan perkembangan adenokarsinoma sel jernih pada serviks.

e. Agen Infeksius

Beberapa agen infeksi yang ditularkan secara seksual, seperti Human Papillomavirus (HPV) dan Herpes Simplex Virus tipe 2 (HSV), dapat menyebabkan mutasi genetik.

f. Human Papilloma Virus (HPV)

HPV, khususnya, diyakini sebagai penyebab utama neoplasia serviks. Proses karsinogenik dimulai ketika virus HPV menginfeksi sel-sel kelenjar serviks, menyebabkan abnormalitas seluler. Bukti lain meliputi korelasi antara infeksi HPV dengan kondiloma serviks, keberadaan koilositosis atipikal sebagai indikator displasia ringan hingga sedang, serta identifikasi antigen dan DNA HPV pada lesi serviks.

g. Virus Herpes Simpleks

Meskipun tidak ditemukan bukti langsung HPV-2 dalam sel tumor, metode hibridisasi in situ telah mengungkap keberadaan RNA Herpes Simplex Virus tipe 2 (HSV) pada sampel jaringan wanita dengan displasia serviks. Selain itu, DNA virus telah diidentifikasi dalam sel tumor menggunakan teknologi DNA rekombinan. Sekitar 60% pasien dengan neoplasia intraepitel serviks (CIN) dan 90% pasien dengan kanker serviks invasif diduga terinfeksi oleh virus ini.

h. Merokok

Merokok telah diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk kanker serviks, khususnya karsinoma sel skuamosa. Mekanisme yang mungkin meliputi aktivitas mutagenik langsung pada lendir serviks atau efek immunosupresif tidak langsung. Wanita perokok memiliki konsentrasi toksin yang lebih tinggi dalam

lendir serviksnya. Kombinasi toksin ini dengan infeksi HPV dapat merusak DNA sel epitel skuamosa, memicu transformasi maligna. (Jasmine, 2024)

2. Faktor Risiko yang Diperkirakan

a. Kontrasepsi Oral

Penggunaan pil kontrasepsi oral dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker ovarium, baik jinak maupun ganas. Namun, hasil penelitian tidak selalu konsisten, dan beberapa studi gagal mempertimbangkan pengaruh aktivitas seksual dalam estimasi risiko. Meskipun ada klaim bahwa kontrasepsi oral dapat melindungi dari penyakit invasif, temuan ini belum dapat direplikasi secara konsisten.

b. Diet

Diet yang rendah karotenoid dan defisiensi folat juga dianggap sebagai faktor risiko kanker serviks.

c. Etnis dan Faktor Sosial

Wanita dari kelas sosial ekonomi rendah memiliki risiko lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dari kelas sosial ekonomi tinggi. Namun, hubungan ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti aktivitas seksual dan akses terhadap layanan kesehatan. Di Amerika Serikat, wanita kulit hitam, Hispanik, dan Asia memiliki insiden kanker serviks yang lebih tinggi dibandingkan wanita kulit putih, yang mungkin disebabkan oleh faktor sosial ekonomi.

d. Pekerjaan

Paparan terhadap kontaminan seperti debu, logam, bahan kimia, tar, atau oli mesin di tempat kerja dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Saat ini, fokus penelitian juga mencakup pria yang pasangannya didiagnosis menderita kanker serviks. (Jasmine, 2024)

E. Gejala kanker serviks.

Kanker serviks tetap menjadi penyebab kematian utama, khususnya di kalangan wanita berusia 20 hingga 30 tahun, dengan angka kematian mencapai 46.000 jiwa. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan kasus kanker serviks tertinggi. Gejala kanker serviks meliputi pendarahan vagina yang tidak teratur, pendarahan setelah berhubungan seksual atau di luar siklus menstruasi, pendarahan pasca-menopause, serta keluarnya cairan berwarna kemerahan dari vagina. Pada stadium lanjut, gejala dapat mencakup nyeri punggung, pembengkakan kaki, keputihan berbau tidak sedap, dan kesulitan buang air besar. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai gejala-gejala tersebut:

1. Abnormalitas Pendarahan Vagina.

Sebanyak 11% pasien kanker serviks melaporkan mengalami pendarahan pasca-coitus, yaitu pendarahan yang terjadi selama atau setelah berhubungan seksual namun tidak terkait dengan menstruasi. Penyebab umum pendarahan ini meliputi kanker, ektoprion, polip serviks, servitis, Neoplasia Intraepitelial Serviks (NIS), atau peradangan serviks. Pendarahan pasca-coitus dikaitkan dengan prevalensi kanker serviks sebesar 3,0% hingga 5,5% dan prevalensi NIS sebesar 6,8% hingga 17,8% pada wanita.

2. Pendarahan di Luar Menstruasi atau Setelah Berhubungan Seksual.

Gejala lesi prakanker tidak selalu terlihat jelas. Namun, pendarahan di luar siklus menstruasi atau setelah berhubungan intim merupakan salah satu tanda awal dan paling umum dari keganasan invasif. Pendarahan setelah berhubungan seksual, dengan tingkat positif kanker sebesar 75-80%, sangat mengindikasikan perkembangan tumor ulseratif. Pada stadium lanjut, dapat muncul gejala tambahan seperti nyeri panggul akibat tekanan tumor, penyumbatan ureter yang menyebabkan oliguria atau anuria, serta keputihan tidak normal. Gejala awal lainnya meliputi dismenore, amenore, hipermenore, pendarahan antar-menstruasi, pendarahan pasca-coitus, dan pendarahan berlendir yang khas untuk kanker serviks.

3. Pendarahan Vagina Pasca-Menopause.

Menopause, yang terjadi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, biasanya terjadi antara usia 40 hingga 56 tahun dan menandai berakhirnya masa reproduksi. Usia menopause dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, jumlah anak, beban pekerjaan, usia menstruasi pertama, riwayat melahirkan, dan jumlah persalinan. Meskipun terapi hormon dapat meredakan gejala menopause, hal ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker rahim atau payudara.

4. Sekresi Cairan Kemerahan dari Vagina.

Selain nyeri panggul dan menstruasi tidak teratur, keluarnya cairan kemerahan dari vagina merupakan tanda yang perlu diwaspadai. Gejala ini dapat mengindikasikan kanker serviks atau endometrium. Penyebab lain dari keputihan abnormal meliputi gangguan hormonal, stres, kelelahan kronis, peradangan vagina, benda asing dalam vagina, infeksi organ reproduksi (seperti kanker serviks), serta infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau parasit.

5. Keputihan Berbau Tidak Sedap

Keputihan berbau tidak sedap merupakan salah satu gejala kanker serviks, yang paling sering disebabkan oleh infeksi HPV. Proses infeksi dimulai ketika HPV menginfeksi sel epitel melalui luka kecil atau lecet. Virus menempel pada sel

serviks, melepaskan lapisan luarnya, dan mengambil alih mekanisme transkripsi serta translasi sel inang untuk bereplikasi (Paulina, 2019). Proses ini dapat menghasilkan cairan berbau tidak sedap. Kebersihan genital yang baik, seperti mencuci area vagina secara teratur dengan sabun dan air serta mengeringkannya dengan handuk bersih, dapat membantu mencegah hal ini.

6. Nyeri Punggung, Kaki Bengkak, atau Kesulitan Buang Air Besar pada Stadium Lanjut

Kanker serviks, yang ditandai dengan transformasi ganas jaringan serviks, menyebabkan disfungsi organ. Gejalanya meliputi keputihan dan pendarahan tidak teratur yang terjadi berulang. Pada stadium lanjut, pasien mungkin mengalami kesulitan buang air besar, pembengkakan kaki, dan nyeri panggul. Nyeri dapat menjalar ke punggung bawah, paha, dan sendi panggul saat menstruasi, buang air besar, atau berhubungan seksual. Penebalan ligamen serviks dan peradangan kronis parametrium dapat memperburuk rasa sakit. Saat area serviks ditekan, pasien mungkin juga merasakan mual, nyeri di daerah lumbosakral, dan fossa iliaka. Penyebaran ke panggul dan keterlibatan limfatik dapat menyebabkan gejala tambahan seperti nyeri saat buang air kecil, urine berdarah, pendarahan rektal, serta edema pada tungkai bawah. (Ramadhany et al., 2021)

F. Pencegahan Kanker Serviks.

Pencegahan kanker serviks memerlukan strategi yang holistik dan berlapis, dimulai dari tindakan pencegahan primer, seperti meminimalkan paparan terhadap faktor risiko serta meningkatkan cakupan vaksinasi, hingga penerapan langkah-langkah pencegahan sekunder. Dalam konteks pencegahan sekunder, skrining melalui pap smear memiliki peran penting dalam mendeteksi kelainan pada serviks jauh sebelum berkembang menjadi kanker, sehingga memungkinkan intervensi medis yang lebih dini dan efektif. (Surinati et al., 2023)

1. Pencegahan Primer

Setiap individu dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko kanker serviks dengan menerapkan upaya pencegahan primer. Pada tingkat ini, individu tidak hanya terbebas dari rasa sakit dan ketidaknyamanan akibat penyakit ini, tetapi juga tetap dapat mempertahankan produktivitasnya tanpa harus menanggung biaya pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi, atau perawatan lanjutan. Salah satu langkah pencegahan primer yang utama adalah pemberian vaksin HPV.

a. *Pap smear Test*

Pap smear merupakan metode diagnostik yang melibatkan pengambilan sampel jaringan dari serviks menggunakan spekulum. Selanjutnya, dokter akan

mengambil sampel sel-sel dari area serviks untuk dianalisis di laboratorium guna mendeteksi adanya kelainan atau indikasi gejala awal kanker. Pemeriksaan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap sel-sel kanker maupun perubahan prakanker pada serviks. Standar rekomendasi menyarankan agar wanita berusia 21 hingga 29 tahun menjalani pap smear setiap tiga tahun. Metode ini telah lama digunakan dan terbukti sebagai prosedur yang aman serta ekonomis dalam mendeteksi kelainan sel serviks.

b. Tes HPV DNA

Uji HPV-DNA bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan infeksi HPV melalui pengambilan sampel sel serviks menggunakan kapas khusus (Rasjidi, 2008: 53). Pengujian ini menjadi semakin efektif apabila dikombinasikan dengan pap smear, menjadikannya alat yang lebih kuat dalam mendeteksi potensi perkembangan kanker serviks. Umumnya, wanita yang telah memasuki usia 30 tahun lebih cenderung merasa nyaman dalam menjalani pemeriksaan ini. Selain itu, penggunaan kolposkop—sebuah alat pembesar khusus—dapat membantu dokter dalam mengevaluasi keberadaan sel-sel abnormal pada serviks secara lebih mendetail. Jika diperlukan, dokter juga dapat meminta analisis lebih lanjut terhadap beberapa sel melalui prosedur biopsi guna memastikan diagnosis yang lebih akurat.

c. Melakukan vaksinasi HPV

Pemberian vaksin HPV merupakan langkah preventif yang sama pentingnya dalam upaya pencegahan kanker serviks. Vaksin ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga dapat diberikan kepada laki-laki guna mencegah penyebaran virus. Vaksinasi HPV direkomendasikan bagi individu berusia 9 hingga 26 tahun, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dini terhadap kanker serviks. Risiko infeksi HPV, sebagai penyebab utama kanker serviks, tetap ada sepanjang kehidupan seorang perempuan, terlepas dari usia maupun gaya hidupnya.

d. Hindari merokok/paparan asap rokok

Asap rokok mengandung berbagai zat karsinogenik yang dapat memengaruhi organ selain paru-paru. Setelah masuk ke dalam sistem peredaran darah melalui paru-paru, zat berbahaya ini dapat menyebar ke seluruh tubuh. Dibandingkan dengan individu yang tidak merokok, perempuan perokok memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi untuk mengembangkan kanker serviks. Hubungan antara kebiasaan merokok dan kanker sel skuamosa serviks dapat dijelaskan melalui dua mekanisme: pertama, efek immunosupresif dari nikotin yang melemahkan sistem kekebalan tubuh; kedua, mutasi langsung pada lendir serviks akibat zat beracun dalam rokok. Selain itu, untuk mencegah

berbagai infeksi menular seksual, seperti sifilis, HIV/AIDS, gonore, dan klamidia—yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kanker serviks—disarankan untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Oleh karena itu, menghindari kebiasaan merokok, menjaga kesehatan secara menyeluruh, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan menjadi hal krusial dalam menurunkan risiko kanker serviks maupun neoplasia intraepitel serviks. (Surinati et al., 2023)

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini kanker serviks melalui skrining dan identifikasi kelainan sejak tahap awal. Tujuan utama dari pencegahan sekunder adalah meningkatkan kemungkinan penyembuhan melalui diagnosis dini, serta memperlambat atau bahkan menghentikan progresi penyakit. Deteksi dini lesi prakanker, seperti displasia serviks, dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan klinis maupun laboratorium. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, pencegahan sekunder juga memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

- a. Metode pemantauan non-invasif tidak sepenuhnya dapat mencegah neoplasia intraepitel serviks (CIN). Selain itu, prosedur medis yang dilakukan untuk menangani lesi prakanker sering kali berdampak negatif terhadap kesuburan pasien.
- b. Ketersediaan dana serta tenaga medis yang terbatas dapat menghambat efektivitas program pencegahan sekunder. Kurangnya alokasi sumber daya untuk mendukung layanan skrining dan pengobatan dini dapat mengurangi jangkauan program deteksi dini kanker serviks secara optimal. (Surinati et al., 2023)

3. Pencegahan Tersier

“Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan, sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Kanker serviks invasif, yang telah menyebar lebih dalam ke jaringan serviks atau organ di sekitarnya, memerlukan penanganan yang lebih agresif. Salah satu metode utama adalah pembedahan, terutama bagi kanker yang masih dalam stadium awal. Prosedur seperti histerektomi (pengangkatan rahim) sering dilakukan untuk menghilangkan jaringan kanker sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, limfadenektomi atau pengangkatan kelenjar getah bening di sekitarnya juga dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain pembedahan, terapi radiasi sering digunakan, baik sebagai pengobatan utama maupun sebagai terapi tambahan setelah operasi. Radiasi bekerja dengan menghancurkan sel kanker menggunakan sinar berenergi tinggi.

Radioterapi dapat dilakukan secara eksternal (melalui mesin yang memancarkan radiasi ke area kanker) atau internal (brachytherapy), di mana sumber radiasi ditempatkan langsung di dalam atau dekat area serviks. Radioterapi sering dikombinasikan dengan kemoterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

Kemoterapi juga menjadi bagian penting dalam pengobatan kanker serviks invasif, terutama pada stadium lanjut atau ketika kanker telah menyebar ke organ lain. Kemoterapi menggunakan obat-obatan yang membunuh sel kanker atau memperlambat pertumbuhannya. Pada kasus kanker serviks yang sudah metastasis, kemoterapi sering dikombinasikan dengan terapi target atau imunoterapi untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Pengobatan kanker serviks invasif biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien dan stadium penyakit, dengan tujuan utama mengendalikan penyebaran kanker dan meningkatkan kualitas hidup pasien.”

G. Infeksi *Human Papilloma Virus*

Penyebab utama kanker serviks yang paling umum adalah infeksi kronis oleh human papillomavirus (HPV). Infeksi HPV menjadi faktor pemicu utama dalam perkembangan neoplasia intraepitel serviks (CIN) maupun kanker serviks. Terdapat lebih dari seratus genotipe HPV yang berbeda, dan sekitar 80% perempuan berisiko mengalami infeksi. Sebagian besar perempuan yang terinfeksi HPV (sekitar 70 hingga 90%) mampu pulih secara alami dalam rentang waktu satu hingga tiga tahun (Winarto et al., 2022). HPV merupakan salah satu jenis virus yang memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan DNA manusia. Setiap genotipe HPV diidentifikasi dengan nomor tertentu. Di antara berbagai genotipe tersebut, HPV tipe 16 dan 18 bertanggung jawab atas sekitar 70% kasus kanker serviks. Selain infeksi HPV, beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kanker serviks meliputi kebiasaan merokok, status sosial ekonomi rendah, kondisi immunosupresi (seperti pada penderita HIV, penerima transplantasi organ, atau pasien gagal ginjal), serta memiliki banyak pasangan seksual. (Surinati et al., 2023)

H. Fokus Vaksinasi HPV pada Remaja Putri

Kelompok yang paling mendapatkan manfaat dari vaksin HPV adalah remaja putri yang belum pernah menerima imunisasi HPV dalam bentuk apa pun. Para ahli kesehatan masyarakat secara luas merekomendasikan vaksinasi HPV bagi remaja perempuan sebagai langkah pencegahan yang optimal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekolah, pusat layanan kesehatan, dan fasilitas berbasis komunitas merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan vaksinasi bagi remaja perempuan karena lokasinya yang dekat dengan sekolah serta usia mereka

yang berisiko memasuki fase aktivitas seksual. Kelompok usia yang menjadi sasaran utama vaksinasi ini adalah anak perempuan berusia 9 hingga 13 tahun. WHO serta berbagai organisasi internasional lainnya tidak merekomendasikan vaksinasi bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya, karena efektivitas vaksin akan mengalami penurunan yang signifikan setelah individu terinfeksi HPV. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, banyak negara telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong vaksinasi remaja putri sebelum mereka memasuki aktivitas seksual. (Frianto et al., n.d.)

I. Pentingnya Edukasi dalam Pencegahan Kanker Serviks

Edukasi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan kanker serviks, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor risiko, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan deteksi dini. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya langkah pencegahan ini, sehingga angka kejadian kanker serviks tetap tinggi, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, edukasi yang efektif diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan risiko dan tindakan preventif yang dapat dilakukan.

Penyuluhan mengenai kanker serviks harus mencakup berbagai aspek penting, seperti pemahaman tentang HPV, manfaat vaksinasi, serta pentingnya deteksi dini melalui skrining seperti Pap smear dan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Selain itu, edukasi juga harus menekankan pentingnya pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan menghindari perilaku seksual berisiko. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka dan mengurangi risiko terkena kanker serviks. (Surinati et al., 2023)

Target edukasi pencegahan kanker serviks mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja, wanita usia subur, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum. Remaja dan anak muda perlu mendapatkan informasi sejak dini agar mereka memahami pentingnya vaksinasi HPV sebelum terpapar virus. Wanita dewasa juga harus diberikan edukasi tentang pentingnya deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker serviks. Selain itu, tenaga kesehatan harus memiliki pemahaman yang mendalam agar dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong pasien untuk melakukan langkah pencegahan.

Agar edukasi lebih efektif, diperlukan berbagai strategi penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami. Metode yang dapat digunakan meliputi seminar kesehatan, kampanye media sosial, penyebaran brosur dan leaflet, serta

kolaborasi dengan sekolah dan institusi kesehatan. Kampanye berbasis digital juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat luas dengan informasi yang valid dan berbasis ilmiah. Dengan pendekatan yang tepat, edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak individu untuk mengambil langkah pencegahan.

Meskipun edukasi memiliki banyak manfaat, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, mitos seputar vaksinasi HPV, dan keterbatasan akses terhadap informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat akurat dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan edukasi yang berkelanjutan dan strategi yang tepat, diharapkan angka kejadian kanker serviks dapat terus menurun, sehingga lebih banyak perempuan dapat terhindar dari penyakit ini. (Surinati et al., 2023)

J. Sasaran Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan mengenai pencegahan kanker serviks harus menyasar berbagai kelompok masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas dan efektif. Salah satu sasaran utama adalah remaja putri dan wanita usia produktif, karena mereka berisiko lebih tinggi terkena infeksi Human Papillomavirus (HPV), penyebab utama kanker serviks. Edukasi kepada kelompok ini dapat mencakup pentingnya vaksinasi HPV, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta memahami risiko dari perilaku seksual yang tidak aman.

Selain remaja putri, para ibu dan wanita dewasa juga menjadi kelompok sasaran penting. Wanita yang sudah aktif secara seksual perlu memahami pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin seperti Pap smear atau IVA (Inspeksi Visual Asam asetat). Dengan edukasi yang tepat, diharapkan semakin banyak wanita yang sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi perubahan sel abnormal pada serviks sebelum berkembang menjadi kanker. (Suryoadji & Ridwan, Alifaturrasyid Syafaatullah, 2022)

Sasaran berikutnya adalah tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, dan dokter umum yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Mereka perlu dibekali dengan informasi terbaru mengenai pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kanker serviks agar dapat memberikan edukasi yang akurat kepada pasien. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai kanker serviks.

Kelompok masyarakat umum, termasuk suami dan keluarga, juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pencegahan kanker serviks. Dukungan keluarga

sangat penting dalam mendorong wanita untuk melakukan pemeriksaan rutin serta mendapatkan vaksinasi HPV. Suami yang memiliki pemahaman tentang kanker serviks dapat lebih mendukung pasangannya dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah faktor risiko yang dapat memicu penyakit ini.

Terakhir, edukasi juga harus menjangkau pembuat kebijakan dan pemimpin komunitas. Pemerintah, organisasi kesehatan, serta tokoh masyarakat memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung program vaksinasi HPV dan deteksi dini. Dengan adanya dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai, edukasi kesehatan mengenai pencegahan kanker serviks dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga angka kejadian penyakit ini dapat ditekan secara signifikan.(Shelemo, 2023)

K. Strategi Efektif dalam Edukasi Pencegahan Kanker Serviks

Pencegahan kanker serviks memerlukan strategi edukasi yang efektif agar masyarakat memahami risiko dan langkah-langkah perlindungan. Salah satu cara utama adalah meningkatkan kesadaran melalui kampanye informasi yang mudah dipahami. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar kesehatan, dan kolaborasi dengan tenaga medis. Penyampaian informasi yang jelas dan berbasis bukti akan membantu masyarakat memahami pentingnya deteksi dini serta vaksinasi HPV sebagai tindakan pencegahan utama.

Selain penyebaran informasi, edukasi pencegahan harus melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten. Dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya dapat memberikan penyuluhan di puskesmas, rumah sakit, maupun komunitas. Mereka dapat menjelaskan faktor risiko, gejala awal, dan pentingnya pemeriksaan rutin seperti tes Pap smear dan IVA (Inspeksi Visual Asam asetat). Interaksi langsung antara tenaga medis dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman serta menghilangkan ketakutan atau mitos yang beredar.(Faisal et al., 2022)

Selanjutnya, integrasi edukasi pencegahan dalam kurikulum sekolah juga menjadi langkah efektif. Dengan memasukkan materi tentang kesehatan reproduksi dan kanker serviks dalam pelajaran biologi atau pendidikan kesehatan, generasi muda dapat memahami sejak dini pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Hal ini juga dapat membantu menanamkan kebiasaan sehat, seperti menjaga kebersihan, menghindari perilaku seksual berisiko, dan memahami manfaat vaksinasi HPV.

Peran komunitas dan organisasi masyarakat juga sangat penting dalam mendukung edukasi pencegahan. Program edukasi berbasis komunitas, seperti diskusi kelompok atau penyuluhan ibu-ibu PKK, dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih personal. Komunitas juga dapat berperan dalam

mengajak anggotanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai kanker serviks.

Terakhir, dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang memadai sangat diperlukan agar edukasi pencegahan dapat berjalan optimal. Program vaksinasi HPV gratis atau bersubsidi, layanan pemeriksaan rutin yang mudah diakses, serta regulasi terkait edukasi kesehatan dapat membantu menekan angka kejadian kanker serviks. Dengan kombinasi strategi yang efektif, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan angka kejadian kanker serviks dapat berkurang secara signifikan.

L. Tantangan dalam Pelaksanaan Edukasi

Pelaksanaan edukasi pencegahan kanker serviks menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan. Banyak wanita masih kurang memahami risiko kanker serviks dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Kurangnya informasi yang mudah diakses dan masih adanya stigma terhadap penyakit ini menyebabkan rendahnya minat untuk mengikuti program vaksinasi HPV atau pemeriksaan rutin seperti Pap smear dan IVA.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau pedesaan. Tidak semua fasilitas kesehatan menyediakan vaksinasi HPV atau layanan deteksi dini yang memadai. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, biaya yang masih dianggap mahal, serta kurangnya tenaga medis yang terlatih menjadi hambatan dalam upaya edukasi dan pencegahan kanker serviks.(Cut Mutiya Bunsal, 2021)

Faktor budaya dan sosial juga menjadi kendala dalam pelaksanaan edukasi. Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa membicarakan kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu, sehingga informasi mengenai pencegahan kanker serviks sulit diterima. Selain itu, adanya mitos dan kesalahpahaman mengenai vaksinasi HPV, seperti anggapan bahwa vaksin ini dapat mempengaruhi kesuburan, membuat sebagian orang enggan untuk menerimanya.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga edukator maupun materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami, juga menjadi tantangan. Banyak program edukasi yang masih menggunakan metode penyuluhan konvensional tanpa pemanfaatan teknologi atau media digital yang lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Tanpa inovasi dalam cara penyampaian informasi, edukasi tentang pencegahan kanker serviks mungkin tidak mampu menarik perhatian dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat.

Terakhir, dukungan kebijakan dan pendanaan yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan edukasi pencegahan kanker serviks.

Meskipun beberapa program vaksinasi HPV sudah disediakan secara gratis atau bersubsidi, cakupan program ini masih terbatas di beberapa daerah. Diperlukan komitmen lebih besar dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa program edukasi dan pencegahan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh lapisan masyarakat(Mumekh et al., 2022)”

M. Studi Kasus dan Best Practice tentang Edukasi Pencegahan Kanker Serviks

Salah satu studi kasus sukses dalam edukasi pencegahan kanker serviks adalah program vaksinasi HPV di Australia. Pemerintah Australia meluncurkan program vaksinasi HPV gratis bagi remaja putri sejak tahun 2007 dan kemudian diperluas untuk remaja laki-laki. Program ini didukung dengan kampanye edukasi yang masif melalui sekolah, media sosial, serta fasilitas kesehatan. Hasilnya, Australia berhasil menurunkan angka infeksi HPV secara signifikan dan diperkirakan akan menjadi salah satu negara pertama yang berhasil mengeliminasi kanker serviks sebagai masalah kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, salah satu contoh praktik terbaik dalam edukasi pencegahan kanker serviks adalah program "Cervical Cancer Awareness Movement" yang dilakukan oleh berbagai organisasi kesehatan dan komunitas. Program ini menyasar wanita usia produktif dengan memberikan penyuluhan, layanan deteksi dini gratis, serta vaksinasi HPV di beberapa daerah. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini mampu menjangkau kelompok yang sulit mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan.(Ngadiyono, Aziyah, 2017)

Studi kasus lainnya datang dari Rwanda, yang berhasil melaksanakan program vaksinasi HPV secara nasional meskipun merupakan negara dengan sumber daya terbatas. Pemerintah Rwanda bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menyediakan vaksin HPV gratis bagi anak perempuan usia sekolah. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan melalui sekolah, pusat kesehatan, serta pemimpin komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi dan deteksi dini kanker serviks. Keberhasilan Rwanda menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, program pencegahan dapat berhasil bahkan di negara dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan.(Mumekh et al., 2022)

Best practice lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam edukasi kesehatan, seperti aplikasi seluler dan media digital untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker serviks. Di beberapa negara, aplikasi kesehatan yang menyediakan informasi mengenai HPV, vaksinasi, serta jadwal pemeriksaan telah membantu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan deteksi dini. Pemanfaatan media sosial dan influencer kesehatan juga terbukti efektif dalam menyebarluaskan

informasi yang akurat kepada kelompok usia muda.(Sumarmi, Salmah Arafah, Ernawati, Kamriana, Mantasia & Alwi, Sri Kurnia Sah Puteri, 2024)

Kesuksesan berbagai program ini menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional, yang mencakup vaksinasi gratis, kampanye edukasi berbasis komunitas, keterlibatan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi, sangat penting dalam upaya pencegahan kanker serviks. Dengan meniru dan menyesuaikan best practice dari berbagai negara sesuai dengan kondisi lokal, diharapkan program edukasi pencegahan kanker serviks dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.(Ramadhany et al., 2021)

N. Kesimpulan

Edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kanker serviks. Dengan penyuluhan yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya vaksinasi HPV, deteksi dini, dan gaya hidup sehat sebagai langkah preventif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan media, penyebaran informasi yang benar dan akurat dapat membantu menurunkan angka kejadian kanker serviks di masa depan. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah harus terus ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari kanker serviks.

O. Referensi

- Bahri, S., Caesarrani, E., Amelia, A., & Rahayu, Y. (2024). *Edukasi Deteksi Pencegahan Kanker Leher Rahim Melalui Vaksinasi HPV di SMAN 8 Kota Pekanbaru* *Education on Detection and Prevention of Cervical Cancer Through HPV Vaccination at SMAN 8 Pekanbaru City*, 4(1).
- Cut Mutiya Bunsal. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Vaksin Hpv Melalui Media Vidio Terhadap Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Usia Subur Di Desa Wori Minahasa Utara. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(1), 131–138. <https://doi.org/10.37304/enggang.v2i1.10714>
- Faisal, M., Dhuha, A., Irawan, M. P., Juwita, S., & Wulandini, P. (2022). Edukasi Kanker Serviks dan Efektivitas Vaksin HPV Sejak Dini di SMAN 2 Pekanbaru. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.36565/jak.v4i2.359>
- Frianto, D., Prof, M. M., & Diantini, A. (n.d.). *Wanita & kanker serviks*.
- Jasmine, K. (2024). Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2(4).

- Mumekh, T. H. ., Bunsal, C. M., & Basso, S. (2022). Health Education Human Papilloma Virus (Hpv) Vaccination In School Children On The Knowledge Attitudes Of Teachers. *Jurnal Kesehatan : Amanah Prodi Ners Universitas Muhammadiyah Manado*, 6(2), 10–21.
- Ngadiyono, Aziyah, S. (2017). Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Servik; Studi Kasus Di Rsup Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Riset Kesehatan*. <https://doi.org/10.31983/jrk.v6i1.2085>
- Ramadhany, S. A., Dewi, I., & Ernawati. (2021). Efektifitas Pendidikan Kesehatan Dengan Pemutaran Video Tentang Vaksin HPV Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Niat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dan Penelitian Keperawatan*, 1(4), 434–440.
- Shelemo, A. A. (2023). Counseling on the Importance of the HPV Vaccine to Prevent Cervical Cancer as Early as Possible. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Sumarmi, Salmah Arafah, Ernawati, Kamriana, Mantasia, R. N., & Alwi, Sri Kurnia Sah Puteri, D. (2024). *Implikasi Edukasi Pencegahan Kanker Serviks Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Pengetahuan Wanita Di Bantul Yogyakarta*. 03.
- Surinati, I. D. A. K., Runiari, N., & Sipahutar, I. E. (2023). Edukasi Pencegahan Kanker Serviks dengan Media Audiovisual terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wahana Usada*, 5(2), 91–99. <https://doi.org/10.47859/wuj.v5i2.413>
- Suryoadji, K. A., & Ridwan, Alifaturrasyid Syafaatullah, F. K. (2022). Vaksin HPV Sebagai Strategi Pencegahan Kanker Serviks Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia*, 10(1), hal 114-120. <https://bapin-ismki.e-journal.id/jimki/article/download/521/249>

P. Glosarium

CIN	: Cervical Neoplasia Intraepitel
DES	: Dietilstilbesterol (DES)
HPV	: Human Papillomavirus (HPV)
HSV	: Herpes Simplex Virus
WUS	: Wanita Usia Subur

PROFIL PENULIS



Baiq Eka Putri Saudia, S.SiT., M.Keb., Lahir di Mekkah, Saudi Arabia, 10 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D IV Kebidanan, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 lulus CPNS kemudian sampai dengan sekarang menjadi PNS di Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Asuhan Masa Nifas dan Menyusui, Asuhan Neonatus Bayi dan Balita dan Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: saudiaputrieka86@gmail.com



Emilda AS, S.ST., MPH., lahir di Labuhan Haji, 05 Juli 1972. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Prodi Kebidanan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis Merupakan lulusan UGM untuk program magister Public Health. Penulis aktif sebagai dosen pengajar, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian serta menulis publikasi ilmiah yang dipublikasi untuk skala nasional maupun di jurnal internasional bereputasi. Rekam jejak penulis dapat dilihat di Profil SINTA penulis dengan ID: 6140741. Email: emilda@poltekkesaceh.ac.id. Saat ini penulis mengajar mata kuliah

Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL dan Imunisasi. Penulis saat ini menjabat sebagai Pengurus IBI Cabang Kota Langsa sebagai Sekretaris Periode 2018-2022 serta Pengelola Jurnal Femina.

PROFIL PENULIS



Dr. Irnawati, S.Si.T., M.Kes., Lahir di Banda Aceh, 21 September 1974, merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, berdomisili di Banda Aceh. Berlatar belakang Pendidikan D III Kebidanan, D IV Bidan Pendidik, S2 KIA/Kesehatan Reproduksi, dan melanjutkan Pendidikan S3 peminatan Ilmu Kedokteran. Sebagai seorang Dosen, penulis aktif melakukan berbagai penelitian, pengabdian Masyarakat serta publikasi berupa artikel dan buku yang berhubungan dengan keilmuan yaitu pada bidang Kebidanan dan kesehatan reproduksi perempuan. Saat ini aktif dalam organisasi Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) dan menjadi tim penilai (Asesor) akreditasi program Studi Kebidanan pada LAMPTKes. Penulis juga menjadi narasumber dan fasilitator pengembangan kurikulum Program Studi Kebidanan dan menjadi tim reviewer serta panel expert soal uji kompetensi Bidan Nasional. Selain itu juga menjadi bagian dari core team pengembangan OSCE Kebidanan Nasional.



Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb., Penulis lahir di Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung 24 November 1994. Jenjang Pendidikan D3 Kebidanan ditempuh di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Provinsi Lampung lulus tahun 2015 dengan predikat sangat memuaskan, jenjang pendidikan S1 Kebidanan ditempuh di Universitas Airlangga Kota Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dengan predikat sangat memuaskan, jenjang Pendidikan Profesi Kebidanan ditempuh di Universitas Airlangga Kota Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2019 dengan predikat sangat memuaskan, serta pendidikan S2 Kebidanan ditempuh di Universitas Padjadjaran Kota Bandung Jawa Barat lulus tahun 2022 dengan predikat dengan *Cumlaude*. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai bidan pelaksana di klinik pratama dan praktik mandiri bidan selama 3 tahun. Sejak tahun 2023 penulis aktif sebagai dosen dan sekretaris program studi pendidikan profesi bidan di Politeknik Aisyiyah Pontianak. Penulis dapat dihubungi melalui Email: ayuknovalina@gmail.com atau nomor HP : 085658795774

PROFIL PENULIS



Tinuk Esti Handayani, SST.,M.Kes., Lahir di Madiun, 17 Maret 1969. P Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Madiun tahun 1988. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Sutomo Surabaya tahun 2002. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Airlangga Surabaya 2005. Lulus Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Kebidanan dan aktif

sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah dibidang Kebidanan. Penulis mengajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, KB dan Kesehatan Reproduksi, Manajemen Tumbuh Kembang Anak, Askeb Kehamilan, Askeb Menopause sejak tahun 2000 sampai sekarang, penulis juga aktif melaksanakan penelitian setiap tahun. Buku yang pernah ditulis antara lain: Modul Ajar KB dan Kesehatan Reproduksi, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Modul Ajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Modul Praktikum KB dan Kesehatan Reproduksi, Buku panduan metode UBama dan Panduan Peka ASI, Media edukasi MamaKia untuk memantau Deteksi dini kehamilan. Penulis juga aktif sebagai anggota IBI sejak tahun 2002-sekarang Keinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan mendorong penulis untuk menulis buku. Kebidanan penulis juga ingin mewujudkan terbitnya buku-buku yang bermanfaat dan relevan dengan kebidanan dari hasil-hasil penelitian Ibu nifas ,Tumbuh kembang anak. Semoga buku-buku yang kami tulis bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa Kebidanan dan Masyarakat umum. Email Penulis: tinukest@gmail.com.

Motto: "Living your life well"

Buku *"Bunga Rampai: Kesehatan Reproduksi di Era Modern"* menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai isu penting yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dalam konteks kehidupan masa kini. Perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi medis, serta pergeseran nilai sosial dan budaya telah membawa dampak signifikan terhadap cara pandang dan penanganan kesehatan reproduktif di masyarakat.

Melalui pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini mengupas berbagai tantangan dan peluang dalam upaya menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan reproduksi. Diharapkan, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam memperkuat kesadaran serta kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan reproduksi yang optimal.

Buku "Bunga Rampai: Kesehatan Reproduksi di Era Modern" menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai isu penting yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dalam konteks kehidupan masa kini. Perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi medis, serta pergeseran nilai sosial dan budaya telah membawa dampak signifikan terhadap cara pandang dan penanganan kesehatan reproduktif di masyarakat.

Melalui pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini mengupas berbagai tantangan dan peluang dalam upaya menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan reproduksi. Diharapkan, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam memperkuat kesadaran serta kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan reproduksi yang optimal.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-40-4



9

786347

219404